

Primeros Auxilios

Curso de primeros auxilios

Con el apoyo de





Contenido temático



UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS

UNIDAD 2. APOYO VITAL BÁSICO

UNIDAD 3 HEMORRAGIAS

UNIDAD 4. ESTADO DE SHOCK

UNIDAD 5. ESGUINCES, LUXACIONES Y FRACTURAS

UNIDAD 6. QUEMADURAS

UNIDAD 7. CONVULSIONES Y EPILEPSIA

UNIDAD 8 INTOXICACIONES Y ENVENENAMIENTOS

UNIDAD 9. MATERIALES QUE COMPONEN UN BOTIQUIN





Puntualidad para el inicio y para los recesos



Respeto a participantes e instructor



Atención



Participación



Celulares en silencio o en vibrador



Expectativas y compromisos

EXPECTATIVAS



COMPROMISOS



Objetivos

- ✓ **Objetivo General.** Aportar a los participantes conceptos y procedimientos para que puedan brindar primeros auxilios a personas que pudieran sufrir algún accidente o enfermedad repentina.
- ✓ **Objetivo particular.** Al finalizar el curso los participantes utilizarán sus habilidades y destrezas adquiridas para aplicar las técnicas de salvamento y procedimientos ya especificados para actuar de manera acertada, salvaguardar la vida de sus compañeros de trabajo en cualquier situación de accidente o enfermedad repentina cumpliendo con los requerimientos legales.



Es el punto en el que debemos prestar mayor atención.

Regla del yo

1. **Primero yo**
2. **Después yo**
3. **Al último yo**

Regla del equipo

1. **Primero yo**
2. **Después mi equipo**
3. **Al último la víctima**

UNIDAD 1

INTRODUCCIÓN

Objetivo: Al finalizar el tema los participantes comprenderán los aspectos básicos requeridos para proporcionar primeros auxilios en su etapa inicial.

Las lesiones por accidentes:

- Ocurren en sitios y situaciones inesperadas.
- El tiempo es vital.
- La atención primaria debe ser eficiente e inteligente.



Evaluación de la escena

La evaluación del escenario se efectúa mediante la estimación de las ***SES: seguridad, escena y situación.***



FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS

- ✚ Hacer entrega de el lesionado a los cuerpos de rescate.
- ✚ En caso de contar con equipo de primeros auxilios, se realizará el inventario, del equipo que requiera mantenimiento, así como, los medicamentos utilizados, y la reposición de los mismos.
- ✚ Mantener actualizado, vigente y en buen estado los botiquines.

Activación del servicio médico de urgencias

- ✓ Marque el 911.
- ✓ Identifíquese y de ser posible e indique el número de teléfono de donde llama.
- ✓ Indique si se trata de una urgencia o un traslado.
- ✓ Indique la localización precisa del incidente.
- ✓ Precise si se requieren servicios de urgencia de tipo no médico.
- ✓ Relate la naturaleza del incidente.
- ✓ De ser posible, estime el número de personas lesionadas.
- ✓ Precise las lesiones, los antecedentes, los hallazgos y el tratamiento de los afectados.
- ✓ Siga las instrucciones del médico o técnico regulador.
- ✓ Sea siempre el último en colgar.

¿URGENCIA O EMERGENCIA?

APRENDE A DIFERENCIARLAS, PUEDE HACER LA DIFERENCIA



URGENCIA

Situación que requiere atención médica rápida, pero que generalmente **NO** pone en riesgo inmediato la vida.

VS

EMERGENCIA

Situación que pone en riesgo la vida, una extremidad o una función vital y requiere **ATENCIÓN INMEDIATA.**



EJEMPLOS

-  Esguince de tobillo
-  Fiebre alta sin dificultad respiratoria
-  Dolor abdominal moderado
-  Herida que requiere sutura

EJEMPLOS

-  Paro cardiorrespiratorio
-  Infarto agudo al miocardio
-  EVC (derrame cerebral)
-  Hemorragia severa
-  Dificultad respiratoria grave



NECESITA **ATENCIÓN PRONTA**, PERO PUEDE ESPERAR UN TIEMPO LIMITADO.



CADA MINUTO CUENTA.

REGLA RÁPIDA



URGENCIA =
ATENCIÓN RÁPIDA



EMERGENCIA =
ATENCIÓN INMEDIATA



ADVANCED
CRITICAL CARE

♥ CONOCER LA DIFERENCIA TAMBIÉN ES **SALVAR VIDAS**



EMERGENCIA

- Peligro inminente para la vida o funciones vitales
- Riesgo de daño irreversible o muerte en poco tiempo
- Requiere atención inmediata

Ejemplos: paro cardíaco, hemorragia incontrolable, evisceración



URGENCIA

- Afecta la salud o bienestar, sin riesgo vital inmediato
- Puede esperar un tiempo razonable sin consecuencias graves
- Se atiende después de las emergencias

Ejemplos: fracturas con sangrado controlado, heridas superficiales, dolor intenso sin afectación vital



RESUMEN

En emergencia se actúa **YA**, en urgencia se actúa **PRONTO**

**ADVANCED**
CRITICAL CARE



¿Quién debe Administrar el Botiquín de Primeros Auxilios?

Debe ser una persona **designada y capacitada** en primeros auxilios:



Brigadista de Emergencia



Personal de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)



Supervisor o Responsable de Área

Responsabilidades del Encargado:



Revisar el contenido del botiquín



Verificar fechas de vencimiento



Reponer insumos usados



Mantener limpio y ordenado



Ubicar en lugar visible y accesible



Llevar un registro de uso

¡ Importante!

Normativas como **OSHA indican** que las empresas deben garantizar la disponibilidad de primeros auxilios y personal capacitado, especialmente cuando no hay acceso cercano a servicios médicos





BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

TU PRIMER RECURSO, PUEDE HACER LA DIFERENCIA

El botiquín de primeros auxilios es un conjunto de materiales y medicamentos básicos para brindar atención inmediata en caso de lesiones o emergencias menores, hasta recibir ayuda profesional.

RECUERDA

- ✓ Revisa tu botiquín cada 3 meses.
- ✓ Reemplaza lo usado o vencido.
- ✓ Manténlo limpio, ordenado y en un lugar accesible.

¿QUÉ DEBE CONTENER?

- 1. PROTECCIÓN PERSONAL**
 - Guantes desechables
 - Mascarilla de RCP
 - Alcohol en gel
- 2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**
 - Solución salina o suero fisiológico
 - Alcohol al 70%
 - Yodopovidona o clorhexidina
 - Toallitas desinfectantes
- 3. CURACIONES Y COBERTURAS**
 - Gasas estériles (varios tamaños)
 - Apósitos adhesivos
 - Vendas elásticas
 - Vendas de gasa
 - Esparadrapo / Cinta adhesiva
 - Algodón
 - Apósitos oculares
- 4. INSTRUMENTAL BÁSICO**
 - Tijeras de punta roma
 - Pinzas
 - Termómetro
- 5. MEDICAMENTOS BÁSICOS**
 - Analgésico (paracetamol)
 - Antiinflamatorio (ibuprofeno)
 - Antihistamínico
 - Antidiarreico
 - Antiséptico tópico
 - Crema para quemaduras
 - Sales de rehidratación oral
- 6. OTROS ELEMENTOS**
 - Linterna pequeña
 - Manta térmica
 - Libreta y lápiz
 - Manual de primeros auxilios

¿CÓMO USARLO?

- 1. EVALÚA LA SITUACIÓN**
Asegúrate de que el entorno sea seguro para ti y para la persona lesionada.
- 2. PROTÉGETE**
Usa guantes y aplica medidas de bioseguridad.
- 3. EXAMINA A LA PERSONA**
Identifica la lesión o problema y brinda el tratamiento adecuado.
- 4. TRATA LA LESIÓN**
Limpia, desinfecta, cubre o inmoviliza según sea necesario.
- 5. BUSCA AYUDA SI ES NECESARIO**
Si la lesión es grave o la persona no mejora, llama a emergencias o traslada a un centro médico.

¿PARA QUÉ SIRVE?

- ✓ Cortes y heridas menores
- ✓ Golpes y contusiones
- ✓ Quemaduras leves
- ✓ Torceduras y esguinces
- ✓ Reacciones alérgicas leves
- ✓ Emergencias menores mientras llega ayuda profesional

NÚMEROS DE EMERGENCIA

Emergencias médicas: 107
Bomberos: 116
Policía: 105

ANTE UNA EMERGENCIA, LA CALMA Y EL CONOCIMIENTO SALVAN VIDAS.

PREPARADOS PARA SALVAR VIDAS

DISCIPLINA ENTRENAMIENTO VOCACIÓN



MALETÍN DE TRAUMA

EQUIPO ESENCIAL PARA SALVAR VIDAS

Diseñado para la atención inmediata de víctimas en situaciones de emergencia y trauma. Conoce su contenido, ubicación y uso adecuado.

1. VÍA AÉREA Y OXIGENACIÓN

- Cánulas orofaríngeas (varios tamaños)
- Cánulas nasofaríngeas (varios tamaños)
- Mascarilla de resucitación (BVM)
- Reservorios para BVM
- Cánula de Guedel
- Lubricante hidrosoluble
- Dispositivo supraglótico (LMA)
- Tubo endotraqueal (varios tamaños)
- Jeringas 10 ml (para inflar cuff)
- Fijador de tubo

2. CONTROL DE HEMORRAGIAS

- Torniquetes (CAT o similares)
- Gasas hemostáticas
- Venda de compresión (tipo israel)
- Vendajes elásticos
- Apósitos abdominales
- Cinta adhesiva
- Guantes de nitrilo (pares)

3. CIRCULACIÓN Y ACCESO VENOSO

- Catéteres IV (14G, 16G, 18G)
- Jeringas (3, 5, 10 ml)
- Agujas
- Solución salina 0.9% (bolsas)
- Llaves de 3 vías
- Equipos de venoclisis
- Venda elástica cohesiva
- Tijeras de trauma

4. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO

- Estetoscopio
- Tensiómetro manual
- Termómetro
- Oxímetro de pulso
- Linterna clínica
- Glucómetro
- Pupímetro
- Marcador / Bolígrafo
- Tarjetas de evaluación
- Guía rápida de protocolos

5. INMOVILIZACIÓN

- Férulas (SAM splint o similar)
- Collarines cervicales (varios tamaños)
- Tabla espinal corta
- Cinchas de sujeción
- Inmovilizador de cabeza
- Venda triangular
- Manta térmica

6. OTROS Y APOYO

- Tijeras de trauma
- Pinza Kelly
- Bisturí / Cuchilla
- Cinta adhesiva
- Cubrebocas
- Manta térmica
- Bolsa para desechos
- Libreta y bolígrafo
- Silbato
- Desinfectante de manos

PRINCIPIOS DE USO

- A. EVALÚA RÁPIDAMENTE** la escena y asegura tu seguridad.
- B. SIGUE EL PROTOCOLO ABCDE** del trauma.
- C. UTILIZA EL EQUIPO** adecuado para cada situación.
- D. REEVALÚA** constantemente al paciente.
- E. DOCUMENTA Y COMUNICA** los hallazgos.

PROTOCOLO ABCDE DEL TRAUMA

- A - VÍA AÉREA**
Asegura la vía aérea con control cervical.
- B - RESPIRACIÓN**
Evalúa la respiración y oxigenación.
- C - CIRCULACIÓN**
Controla hemorragias y evalúa perfusión.
- D - DISCAPACIDAD**
Evalúa el estado neurológico.
- E - EXPOSICIÓN**
Expón al paciente, previene hipotermia y busca lesiones.

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO

- ✓ Revisa el contenido al inicio y final de cada turno.
- ✓ Verifica fechas de vencimiento.
- ✓ Reemplaza lo utilizado inmediatamente.
- ✓ Mantén el maletín limpio, ordenado y completo.
- ✓ Asegura que todos conozcan su ubicación y uso.

RECUERDA

La rapidez, el conocimiento y el equipo adecuado hacen la diferencia entre la vida y la muerte. ¡Prepárate, actúa y salva vidas!

USO RÁPIDO: LO QUE NO PUEDE FALTAR

Torniquete Venda de compresión Gasa hemostática Vía aérea BVM Catéter IV Férula Collarín cervical Oxímetro Tijeras de trauma Guantes

PREPARADOS PARA SALVAR VIDAS

DISCIPLINA ENTRENAMIENTO VOCACIÓN

¿QUÉ DEBE TENER UN BOTIQUÍN DE EMERGENCIA?

Un botiquín bien equipado te ayuda a responder mejor
en los primeros minutos.



1 PROTECCIÓN



Guantes



Mascarillas



Gel antiséptico



2 CURACIÓN



Gasas



Apósitos



Vendas



Esparadrapo



Tijeras



3 CONTROL DE SANGRADO



Vendaje compresivo



Apósitos estériles



Torniquete
si corresponde



4 INMOVILIZACIÓN Y SOPORTE



Manta térmica



Férula básica



Bolsa de frío



5 OTROS IMPRESCINDIBLES



Linterna



Libreta



Números de
emergencia



RECOMENDACIONES



1. Revisar vencimientos
periódicamente.



2. Mantenerlo
accesible y visible.



3. Reponer insumos
después de cada uso.



4. Adaptar según el
entorno y necesidades.



Guarda esta lista y compártela.



PREVENIR Y PREPARARSE SIEMPRE



EVALUACIÓN PRIMARIA AL LESIONADO

RÁPIDA • SISTEMÁTICA • ENFOCADA • SALVA VIDAS

OBJETIVO: Identificar y tratar de inmediato las amenazas que ponen en riesgo la vida del paciente.

LA EVALUACIÓN PRIMARIA SE REALIZA EN MENOS DE 60 SEGUNDOS

ÁREA	¿Está abierta y permeable?	¿Está abierta y permeable?	¿Está abierta y permeable?	¿Está abierta y permeable?	¿Está abierta y permeable?
A VÍA AÉREA	• Habla al paciente: "¿Está bien?" • Observa si responde. • Abre la vía aérea con maniobra frente-mentón. • Verifica si hay obstrucciones (cuerpos extraños, sangre, vómito). • Si no responde y no respira, prepara para RCP.	SIGNOS DE ALERTA • No responde • No puede hablar o emitir sonidos • Ruidos anormales (gorgoros, ronquido) • Obstrucción visible • Trauma facial o cervical	NIVEL DE CONCIENCIA (AVPU) A ALERTA Responde a estímulos verbales normalmente. V VERBAL Responde a estímulos verbales. P DOLOR Responde al dolor. U INCONSCIENTE No responde.	APERTURA OCULAR (E) 1 Espontánea 2 A la voz 3 Al dolor 4 Ninguna	RESPUESTA VERBAL (V) 1 Orientado 2 Confuso 3 Palabras inapropiadas 4 Sonidos incomprensibles 5 Ninguna
B RESPIRACIÓN	• Observa expansión del tórax. • Escucha y siente la respiración (ver, escuchar, sentir). • Cuenta la frecuencia respiratoria (normal: 12-20 rpm). • Administra oxígeno si está disponible.	SIGNOS DE ALERTA • No respira • Respiración muy rápida o muy lenta • Esfuerzo respiratorio (uso de músculos accesorios) • Heridas abiertas en tórax • Cianosis (labios o piel azulada)	ESCALA DE GLASGOW 14 Espontánea 13 A la voz 12 Al dolor 11 Ninguna	RESPUESTA MOTORA (M) 6 Obedece órdenes 5 Localiza el dolor 4 Retira al dolor 3 Flexión anormal 2 Extensión anormal 1 Ninguna	PUNTAJE TOTAL: 3 - 15 ≤ 8: Lesión neurológica severa
C CIRCULACIÓN	• Verifica pulso (carotídeo o radial). • Evalúa color de piel, temperatura y humedad. • Busca hemorragias externas y detritas de inmediato. • Si no hay pulso, inicia RCP.	SIGNOS DE ALERTA • Pulso ausente o débil • Piel pálida, fría, sudorosa • Sangrado abundante • Relleno capilar > 2 segundos • Nivel de conciencia disminuido	RESPUESTA MOTORA (M) 6 Obedece órdenes 5 Localiza el dolor 4 Retira al dolor 3 Flexión anormal 2 Extensión anormal 1 Ninguna	PUNTAJE TOTAL: 3 - 15 ≤ 8: Lesión neurológica severa	
D DISCAPACIDAD NEUROLÓGICA	• Verifica nivel de conciencia (AVPU / Glasgow). • Revisa tamaño y reactividad pupilar. • Evalúa fuerza y movimiento en extremidades. • Busca signos de déficit neurológico.	SIGNOS DE ALERTA • No responde, confuso o somnoliento • Pupilas desiguales o no reactivas • Debilidad o parálisis en extremidades • Convulsiones • Dolor de cabeza intenso	RESPUESTA MOTORA (M) 6 Obedece órdenes 5 Localiza el dolor 4 Retira al dolor 3 Flexión anormal 2 Extensión anormal 1 Ninguna	PUNTAJE TOTAL: 3 - 15 ≤ 8: Lesión neurológica severa	
E EXPOSICIÓN Y CONTROL AMBIENTAL	• Expon al paciente completamente. • Busca heridas, deformidades, quemaduras, fracturas. • Previén hipotermia (cubre al paciente). • Controla el ambiente y riesgos del entorno.	SIGNOS DE ALERTA • Traumas ocultos • Quemaduras • Dolor o deformidades • Hipotermia o hipertermia • Riesgo en el entorno (tráfico, fuego, etc.)	RESPUESTA MOTORA (M) 6 Obedece órdenes 5 Localiza el dolor 4 Retira al dolor 3 Flexión anormal 2 Extensión anormal 1 Ninguna	PUNTAJE TOTAL: 3 - 15 ≤ 8: Lesión neurológica severa	

PRIORIDAD: TRATAR PRIMERO LO QUE MATA

Vía aérea obstruida, Respiración inadecuada, Hemorragias masivas, Shock hipovolémico, Lesiones catastróficas

REGLA DE ORO
Si encuentras algo que amenaza la vida, TRÁTALO INMEDIATAMENTE antes de continuar.

NO OLVIDES
✓ Pedir ayuda temprano
✓ Usar EPP
✓ Reevaluar constantemente
✓ Documentar todo

FLUJO DE LA EVALUACIÓN PRIMARIA
Asegura la escena → Aproxima y habla al paciente → Inicia ABCDE → Trata amenazas inmediatas → Reevalúa continuamente → Prepara para el traslado

EVALÚA ACTÚA REVALÚA SALVA VIDAS

EVALUACIÓN SECUNDARIA DEL PACIENTE

EXAMINA A FONDO • NO OLVIDES NADA • DETALLA LO IMPORTANTE • TRATA LO ENCONTRADO

¿QUÉ ES?
Es una evaluación detallada y sistemática que se realiza después de la evaluación primaria y estabilización inicial del paciente. Su objetivo es encontrar lesiones ocultas, determinar la causa del problema y obtener información completa para el tratamiento y transporte adecuados.

¿CUÁNDO REALIZARLA?
✓ Después de estabilizar la vía aérea, respiración y circulación.
✓ Cuando el paciente esté hemodinámicamente estable o en camino al centro asistencial.
✓ Requiere más tiempo y un ambiente seguro.

RECUERDA
La seguridad de la escena y del paciente es primero. Usa EPP y trabaja en equipo.

PASOS DE LA EVALUACIÓN SECUNDARIA

- AMPLIAR SAMPLE**
 - S Síntomas ¿Qué molestias tiene?
 - A Alergias ¿A qué es alérgico?
 - M Medicamentos ¿Qué medicamentos usa?
 - P Patologías ¿Qué enfermedades tiene?
 - L Última ingesta ¿Cuándo fue su última comida/bebida?
 - E Eventos ¿Qué ocurrió? Mecanismo de lesión.
- SIGNOS VITALES COMPLETOS**
 - Frecuencia cardíaca
 - Frecuencia respiratoria
 - Presión arterial
 - Saturación de O₂
 - Temperatura
 - Nivel de conciencia (AVPU/Glasgow)
 - Glucemia (si está disponible)
- HISTORIA DEL PROBLEMA ACTUAL**
 - ¿Qué paso?
 - ¿Cuándo ocurrió?
 - ¿Cómo ocurrieron los hechos?
 - Evolución de los síntomas.
 - Tratamientos previos aplicados.
- EXAMEN FÍSICO DETALLADO**
De cabeza a pies sin olvidar ninguna área.

1 CABEZA
• Contusiones, heridas, deformidades
• Dolor, mareo, visión, audición
• Pupilas: tamaño, reactividad

2 CARA
• Dolor, deformidades, heridas
• Sangrado, sensibilidad

3 CUELLO
• Dolor, movilidad, deformidades
• Sensibilidad, ingurgitación yugular

4 TÓRAX
• Simetría, expansibilidad
• Dolor, deformidades, heridas
• Ruidos respiratorios
• Ruidos cardíacos

5 ABDOMEN
• Inspección (distensión, heridas)
• Auscultación (ruidos intestinales)
• Palpación (dolor, masas, rigidez)
• Percusión (timpanismo, matidez)

6 PELVIS / GENITALES
• Dolor, inestabilidad
• Sangrado, deformidades

7 EXTREMIIDADES SUPERIORES
• Deformidades, heridas, dolor
• Pulso, color, temperatura
• Movilidad, sensibilidad, fuerza

8 EXTREMIIDADES INFERIORES
• Deformidades, heridas, dolor
• Pulso, color, temperatura
• Movilidad, sensibilidad, fuerza

9 ESPALDA
• Dolor, deformidades, lesiones
• Sensibilidad en columna
• Signos de trauma penetrante

5 EVALUACIONES ESPECÍFICAS
Según el caso, realiza pruebas adicionales:
• Neurológica: Glasgow, fuerza, sensibilidad, reflejos.
• Respiratoria: oximetría, capnografía, pico flujo.
• Cardíaca: ECG, dolor torácico, ritmo.
• Abdominal: signos de irritación peritoneal.
• Trauma: pruebas especiales según mecanismo de lesión.

6 EXPOSICIÓN CONTROLADA
• Expon completamente al paciente para buscar lesiones ocultas.
• Mantén privacidad y confort térmico.
• Cubre al paciente después.

7 REEVALUACIÓN CONTINUA
• Repite signos vitales.
• Revisa intervenciones realizadas.
• Detecta cambios y responde oportunamente.

ESCALAS ÚTILES
• Glasgow: Nivel de conciencia
• AVPU: Alerta, Verbal, Dolor, Inconsciente
• Escala de Dolor (EVA): 0 al 10
• Escala de Shock (TRTS): Evalúa perfusión y estado general

CLAVES PARA UNA BUENA EVALUACIÓN
✓ Sé metódico y no te saltes pasos.
✓ Comunica lo que encuentras.
✓ Usa un lenguaje claro y preciso.
✓ Trabaja en equipo.
✓ Confía en tu entrenamiento y experiencia.

¡BANDERAS ROJAS!
• Dificultad para respirar
• Dolor torácico severo
• Sangrado abundante
• Disminución del nivel de conciencia
• Déficit neurológico
• Dolor abdominal intenso / rigidez
• Shock / hipotensión
• Fracturas expuestas o inestables

DOCUMENTA TODO
Registra todos los hallazgos, intervenciones, tiempos y respuesta del paciente. Una buena documentación puede salvar vidas y respalda tu atención.

ABCDE EN MEDICINA

Método de evaluación primaria para identificar y tratar rápidamente problemas que ponen en peligro la vida.



PRINCIPIO CLAVE
Tratar inmediatamente cualquier problema encontrado antes de pasar a la siguiente letra.

A
AIRWAY
(VÍA AÉREA)

- ✓ Verificar que la vía aérea esté permeable.
- 🔍 Buscar obstrucciones por cuerpos extraños, vómito, sangre o inflamación.
- 👤 Realizar maniobras para abrir la vía aérea si es necesario.


OBJETIVO
Garantizar que el aire pueda llegar a los pulmones.

B
BREATHING
(RESPIRACIÓN)

- 🫁 Evaluar frecuencia y esfuerzo respiratorio.
- 👤 Observar movimientos torácicos.
- 📊 Medir saturación de oxígeno.
- 💧 Administrar oxígeno si es necesario.


OBJETIVO
Asegurar una ventilación y oxigenación adecuadas.

C
CIRCULATION
(CIRCULACIÓN)

- 🩺 Valorar pulso, presión arterial y color de la piel.
- 🩸 Identificar hemorragias activas.
- 👤 Evaluar llenado capilar.
- 💧 Iniciar control de sangrado y reposición de líquidos si es necesario.


OBJETIVO
Mantener una perfusión adecuada de los órganos.

D
DISABILITY
(ESTADO NEUROLÓGICO)

- 🧠 Evaluar nivel de conciencia (AVPU o Glasgow).
- 👁️ Revisar pupilas.
- 🩺 Medir glucemia capilar cuando sea necesario.

AVPU	
A	Alerta
V	Responde a Voz
P	Responde a Dolor
U	No responde


OBJETIVO
Detectar alteraciones neurológicas tempranas.

E
EXPOSURE
(EXPOSICIÓN Y ENTORNO)

- 🔍 Examinar completamente al paciente en busca de lesiones.
- 🌡️ Valorar temperatura corporal.
- 🧊 Prevenir hipotermia cubriendo al paciente después de la exploración.


OBJETIVO
Identificar lesiones o problemas ocultos y prevenir complicaciones.

IMPORTANCIA DEL ABCDE

- 🕒 Permite una atención rápida y organizada.
- 🚨 Prioriza problemas que amenazan la vida.
- 🚑 Se utiliza en urgencias, emergencias, trauma y cuidados críticos.
- 🔄 La evaluación debe repetirse continuamente.
- 📋 Ayuda a detectar cambios en el estado del paciente.

EVALUACIÓN DEL PACIENTE ABCDE

Evaluación Sistemática de Emergencia del Paciente Críticamente III



A — Vía aérea
¿Está la vía aérea abierta?



B — Respiración
Evaluar oxigenación y ventilación



C — Circulación
Evaluar la perfusión



D — Discapacidad
Evaluar el estado neurológico



E — Exposición
Buscar problemas ocultos

Vía aérea → Respiración → Circulación → Discapacidad → Exposición

XABCDE VS MARCH

¿QUÉ PRIORIZA CADA ALGORITMO?



XABCDE ENFOQUE CIVIL

Prioriza la fisiología y la evaluación sistemática en un entorno controlado.



EXSANGUINANTE

Control inmediato de hemorragias externas que amenazan la vida.



VÍA AÉREA

Permeabilidad avanzada y protección de la vía aérea con herramientas.



RESPIRACIÓN

Evaluación y manejo ventilatorio. Oxigenación y ventilación efectivas.



CIRCULACIÓN

Perfusión, control de hemorragias internas y estado hemodinámico.



DISCAPACIDAD

Evaluación neurológica rápida (AVDI / Glasgow) y glucemia.



EXPOSICIÓN / AMBIENTE

Exposición completa, búsqueda de lesiones y prevención de hipotermia.



DIFERENTE ORDEN, MISMA META:
 IDENTIFICAR Y TRATAR **LO QUE MATA PRIMERO.**



MARCH ENFOQUE TÁCTICO

Prioriza intervenciones que salvan vidas en entornos hostiles, bajo fuego o con recursos limitados.



MASSIVE HEMORRHAGE

Control de hemorragia masiva con torniquete, vendaje hemostático y empaquetamiento.



AIRWAY

Asegurar y mantener vía aérea con maniobras simples y eficaces.



RESPIRATION

Descompresión torácica con aguja si hay neumotórax a tensión.



CIRCULATION

Reevaluación constante del control de hemorragia y signos de choque.



HYPOTHERMIA / HEAD INJURY

Prevención de hipotermia y manejo de lesión craneal si aplica.



VALORACIÓN XABCDE

EVALUACIÓN INICIAL DEL PACIENTE TRAUMATIZADO



X EXANGUINACIÓN

- ✓ Buscar hemorragias graves.
- ✓ Aplicar torniquetes si es necesario.
- ✓ Usar vendajes compresivos.



A VÍA AÉREA

- ✓ Abrir y despejar la vía aérea.
- ✓ Remover obstrucciones.
- ✓ Usar cánula u otros dispositivos si es necesario.



B RESPIRACIÓN

- ✓ Evaluar la respiración.
- ✓ Administrar oxígeno.
- ✓ Ventilar si es necesario.



C CIRCULACIÓN

- ✓ Verificar pulso y presión arterial.
- ✓ Tratar shock, acceso IV e inmovilización.
- ✓ Evaluar signos de choque y tratar la causa.



D DISCAPACIDAD

- ✓ Evaluación rápida del estado neurológico.
- ✓ Evaluar respuesta a estímulos: AVDN.
- ✓ Controlar tamaño y respuesta pupilar.



E EXPOSICIÓN

- ✓ Desvestir con cuidado para examinar.
- ✓ Evitar hipotermia: manta térmica.
- ✓ Proteger la intimidad del paciente.



UNA EVALUACIÓN SECUENCIAL Y COMPLETA SIGUIENDO:
 EL **XABCDE** GARANTIZA UNA ATENCIÓN RÁPIDA Y EFECTIVA

- ✓ Reconocer rápidamente lesiones y condiciones potencialmente mortales.
- ✓ Priorizar las intervenciones basadas en la urgencia de cada problema.
- ✓ Mantén la **CALMA** Y **AUTOPROTECCIÓN**.
- ✓ Documenta Y **COMUNICA** al equipo médico.




PROTOCOLO MARCH

EVALUACIÓN PRIMARIA DEL PACIENTE EN ATENCIÓN TÁCTICA DE EMERGENCIAS



M HEMORRAGIAS MASIVAS

- ✓ Identificar y controlar hemorragias graves.
- ✓ Aplicar torniquetes y agentes hemostáticos.

A VÍA AÉREA

- ✓ Asegurar vía aérea permeable.
- ✓ Remover obstrucciones.
- ✓ Usar cánulas o técnicas avanzadas si es necesario.



R RESPIRACIÓN

- ✓ Verificar respiración y tórax.
- ✓ Descomprimir tórax si es necesario.
- ✓ Aplicar sello torácico a heridas en el pecho.



C CIRCULACIÓN

- ✓ Evaluar pulso y signos vitales.
- ✓ Tratar shock mediante fluidos IV.
- ✓ Controlar otras hemorragias.



H HIPOTERMIA Y HERIDAS

- ✓ Prevenir hipotermia, mantener calor.
- ✓ Examinar y tratar otras heridas para estabilizar.
- ✓ Usar mantas térmicas y vendajes adecuados.



EL PROTOCOLO **MARCH** GARANTIZA UNA ATENCIÓN RÁPIDA Y EFICIENTE EN SITUACIONES TÁCTICAS DE EMERGENCIA

- ✓ Evalúa y prioriza problemas que amenazan la vida.
- ✓ Actúa con rapidez y seguridad.
- ✓ Documenta y reporta el estado del paciente.




TECC

ATENCIÓN TÁCTICA DE EMERGENCIA A VÍCTIMAS

Su adaptación civil para emergencias policiales, terrorismo o desastres

Nuestro objetivo siempre será salvar vidas de la manera más segura posible.

LAS 3 FASES DEL TECC

1 ZONA DE AMENAZA DIRECTA

ATENCIÓN BAJO AMENAZA DIRECTA

- Escenario de amenaza activa (ej. tirador).
- Prioridad: sacar a los heridos de la zona de peligro inmediato.
- No se realizan procedimientos médicos hasta estar a salvo.

2 ZONA DE AMENAZA INDIRECTA (COBERTURA)

ATENCIÓN ANTE AMENAZAS INDIRECTAS

- El paciente está en una zona segura o "tibia" protegida por la policía.
- Se realiza la evaluación médica completa similar al TCCC.
- Adaptada al uso de recursos civiles.

3 ZONA DE EVACUACIÓN

ATENCIÓN DURANTE LA EVACUACIÓN

- Se realiza en la "zona fría".
- Enfoque: transferencia a los servicios médicos de emergencias (ambulancias civiles).
- Transporte a un hospital cercano y adecuado.

PRINCIPIOS DEL TECC

- SEGURIDAD PRIMERO
- TRABAJO EN EQUIPO
- ATENCIÓN EFECTIVA
- DECISIONES RÁPIDAS
- SALVAR VIDAS

ENTRENAMIENTO, PREPARACIÓN Y ACCIÓN SALVAN VIDAS

TCCC+

ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN COMBATE

El protocolo militar para zonas de guerra.

1 ZONA DE AMENAZA DIRECTA

TCCC (Cuidado Bajo el Fuego)

La prioridad absoluta es ganar el combate. La víctima devuelve el fuego y busca cobertura. El tratamiento se limita a un torniquete rápido.

2 ZONA DE AMENAZA INDIRECTA (COBERTURA) TCCC

(Atención Táctica en el Campo)

La amenaza persiste pero hay cierta cobertura. Se aplica el protocolo MARCH para control de hemorragias masivas, manejo de la vía aérea, circulación, e hipotermia/ojos.

3 ZONA DE EVACUACIÓN

TCCC (Evacuación Táctica)

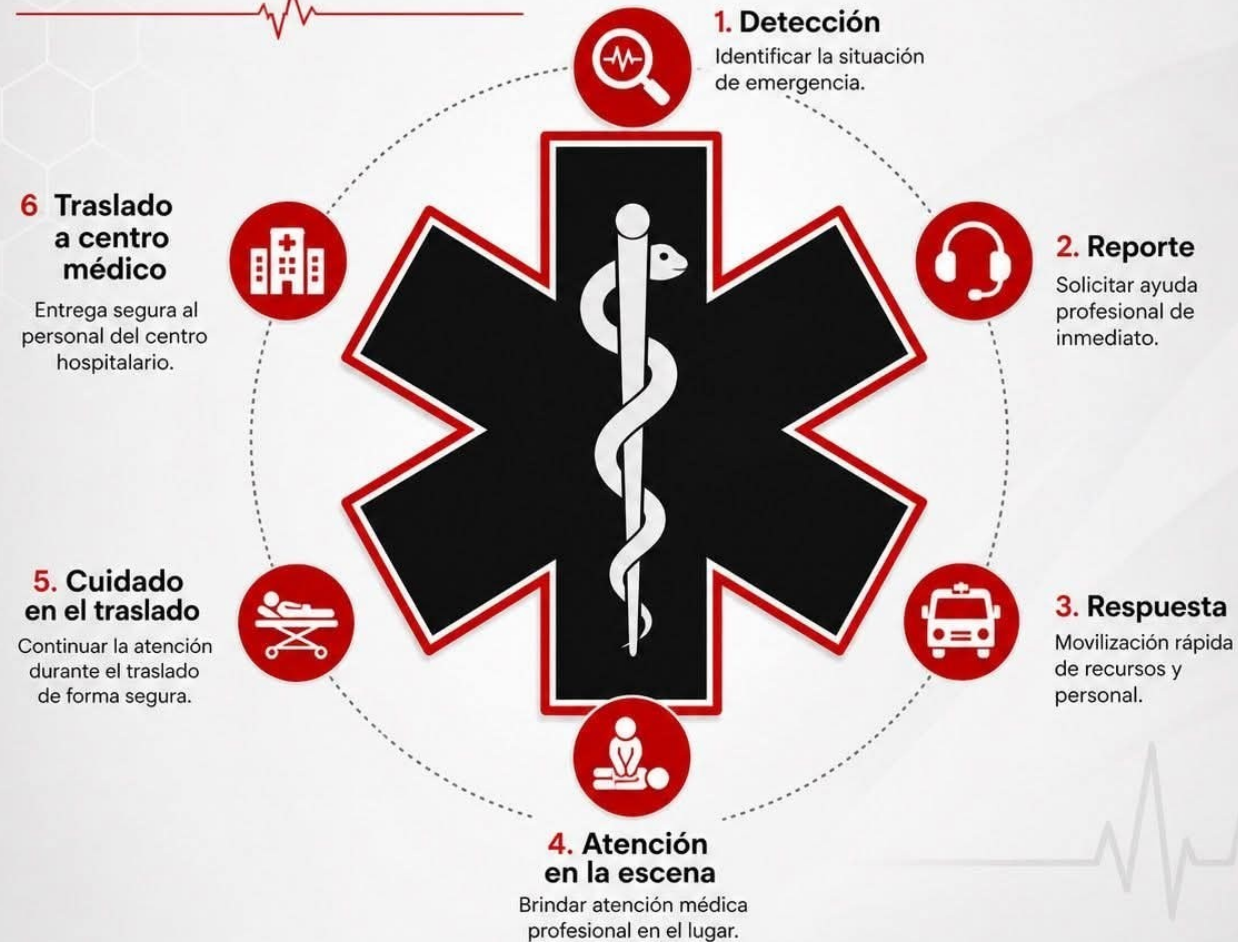
Se traslada al herido en vehículos o aeronaves militares. Se reevalúa constantemente y se prepara al paciente para la entrega médica.

PRINCIPIOS CLAVE

- GANAR EL COMBATE
- PROTOCOLO MARCH
- RE-EVALUAR Y TRATAR
- PREPARAR para ENTREGA MÉDICA

Es esencial controlar el área y administrar un tratamiento que establezca al herido antes del traslado definitivo.

¿QUÉ REPRESENTA LA **ESTRELLA** DE LA VIDA?



SOBRE EL CUERPO HUMANO

Una máquina perfecta e increíble



TOTAL DE DIENTES:
32

Tenemos 32 dientes entre superiores e inferiores.



TOTAL DE HUESOS EN UN ADULTO:
206

Forman el esqueleto, que da forma, soporte y protección al cuerpo.



FILTRO DE LA SANGRE: RIÑONES

Los riñones eliminan desechos y exceso de líquidos de la sangre.



ÓRGANO EXTERNO MÁS GRANDE: LA PIEL

Nos protege del exterior, regula la temperatura y nos permite sentir.



HUESO MÁS GRANDE: FÉMUR (MUSLO)

Es el hueso más largo y fuerte del cuerpo.



HUESO MÁS PEQUEÑO: ESTRIBO (OÍDO)

Es uno de los huesecillos del oído medio y mide aprox. 2,5 mm.



PESO DEL CEREBRO: 1.3-1.4 kg

Es el centro de control del cuerpo, pensamiento, memoria y emociones.



NÚMERO DE NERVIOS DEL CEREBRO: 12 PARES

También llamados nervios craneales; conectan el cerebro con la cara, cabeza, cuello y órganos.



NERVIO MÁS LARGO: NERVO CIÁTICO

Va desde la parte baja de la espalda hasta las piernas y pies.



TOTAL DE PARES DE COSTILLAS: 12 (24 COSTILLAS)

Protegen órganos vitales como los pulmones.



NÚMERO DE RIÑONES: 2

Ubicados a cada lado de la columna vertebral, filtran la sangre y producen orina.



TOTAL DE MÚSCULOS: MÁS DE 600

Trabajan en conjunto para permitir movimiento, postura y funciones vitales.



MÚSCULO MÁS FUERTE: LA MANDÍBULA (MASETERO)

Puede ejercer una fuerza muy potente al masticar.



ÓRGANO QUE BOMBEA LA SANGRE: EL CORAZÓN

Es el motor del sistema circulatorio.



TOTAL DE CAVIDADES DEL CORAZÓN: 4

Dos aurículas y dos ventrículos.



TOTAL DE SANGRE EN UN ADULTO: 5-6 LITROS

La sangre transporta oxígeno, nutrientes y defensas por todo el cuerpo.

INTERPRETACIÓN

El cuerpo humano es una obra maestra de la naturaleza. Cada hueso, músculo, órgano y gota de sangre trabaja en perfecta coordinación para mantenernos vivos, permitirnos movernos, pensar, sentir y soñar. Aunque muchas veces lo damos por sentado, nuestro cuerpo es una estructura increíblemente compleja y eficiente. Cuidarlo, alimentarlo bien, ejercitarlo, descansar y mantener una mente positiva es la mejor forma de honrar esta maravilla que llevamos dentro.

ALGUNAS CURIOSIDADES EXTRA

- Parpadeamos unas 15-20 veces por minuto.
- Inspiramos y expiramos alrededor de 20,000 veces al día.
- El estómago puede producir nuevos jugos digestivos cada 2 semanas.
- Las uñas de las manos crecen más rápido que las de los pies.
- El cerebro puede generar suficiente electricidad para encender una bombilla pequeña.

ANATOMÍA DEL CRÁNEO

ESTRUCTURA QUE PROTEGE, SOSTIENE Y DA FORMA

El cráneo está formado por 22 huesos que protegen el encéfalo, los órganos de los sentidos y forman la estructura de la cara. Se divide en dos partes principales: **neurocráneo** y **viscerocráneo**.

NEUROCRÁNEO (8 HUESOS)

Forma la cavidad craneal que protege el encéfalo.

- FRONTAL**
Forma la frente y la parte superior de las órbitas. Protege la parte frontal del cerebro.
- PARietales (2)**
Forman la parte superior y lateral de la bóveda craneal. Protegen los lóbulos parietales.
- TEMPORALES (2)**
Ubicados a los lados del cráneo. Protegen los oídos y participan en la articulación de la mandíbula.
- OCCIPITAL**
Forma la parte posterior e inferior del cráneo. Protege el cerebelo y el tronco encefálico.
- ESFENOIDES**
Hueso complejo situado en la base del cráneo. Conecta otros huesos y protege estructuras importantes como la hipófisis.
- ETMOIDES**
Se encuentra delante del esfenoide. Forma parte de la cavidad nasal y órbitas. Importante en el olfato.

VISCEROCRÁNEO (14 HUESOS)

Forma la estructura de la cara, las cavidades oral y nasal, y aloja los órganos de los sentidos.

- NASALES (2)**
Forman el puente de la nariz.
- LAGRIMALES (2)**
Pequeños huesos en el ángulo interno de las órbitas. Contribuyen a la producción de lágrimas.
- CIGOMÁTICOS (2)**
Forman los pómulos y parte de las órbitas.
- MAXILARES (2)**
Forman el maxilar superior, el paladar y parte de las órbitas. Contienen los dientes superiores.
- PALATINOS (2)**
Forman la parte posterior del paladar duro y las paredes de la cavidad nasal.
- CORNETES INFERIORES (2)**
Huesos delgados en la cavidad nasal que ayudan a filtrar, calentar y humidificar el aire.
- VÓMER**
Forma la parte inferior del tabique nasal.
- MANDÍBULA**
Único hueso móvil del cráneo. Permite la masticación y el habla. Contiene los dientes inferiores.

¿SABÍAS QUÉ?

Las suturas son uniones fibrosas entre los huesos del cráneo que permiten el crecimiento en la infancia y brindan resistencia en la adultez.



FUNCIONES PRINCIPALES DEL CRÁNEO

- PROTEGE**
El encéfalo y los órganos de los sentidos.
- SOPORTA**
Proporciona puntos de inserción para músculos y ligamentos.
- DA FORMA**
A la cara y mantiene la estructura de la masticación, el habla y la expresión facial.
- FUNCIÓN**
Permite funciones esenciales como la masticación, el habla y la expresión facial.

ENFERMERÍA EN ACCIÓN

Conocer la anatomía del cráneo es fundamental para valorar, prevenir lesiones, brindar cuidados seguros y entender procedimientos clínicos con precisión y empatía.

Nurse Gabrielle

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Conoce las palabras clave de la **anatomía**
y el **cuerpo humano**.

HEPATO
Hígado.

CITO
Célula.

CÉFALO
Cabeza.

TÓRACO
Tórax (pecho).

NEURO
Nervio o sistema nervioso.

MIELO
Médula ósea.

ÓCULO
Ojo.

ESPLENO
Bazo.

CARDIO
Corazón.

NEFRO
Riñón.

GASTRO
Estómago.

ADENO
Glándula.

ARTRO
Articulación.

ENTERO
Intestino.

CISTO
Vejiga (urinaria).

OSTEO
Hueso.

DERMO
Piel.

PROCTO
Recto.

HEMO
Sangre.

MIO
Músculo.

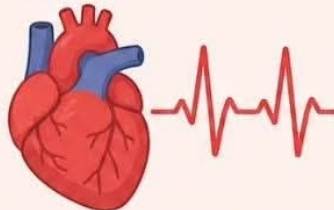
USO PRÁCTICO

- ✓ Facilita la comunicación médica.
- ✓ Mejora la comprensión anatómica.
- ✓ Es esencial en la evaluación y registro clínico.
- ✓ Ayuda a identificar estructuras, sistemas y funciones del cuerpo.

“Conocer la **TERMINOLOGÍA** es el primer paso
para brindar una **MEJOR ATENCIÓN**.”

SIGNOS VITALES

 **FRECUENCIA CARDIACA**



60-100
LTS X MIN

 **FRECUENCIA RESPIRATORIA**



12-18
RESP X MIN

 **SATURACION DE O2**



95%-100%

 **TENSION ARTERIAL**



120/80
mmhg

 **GLUCEMIA CAPILAR**



70-100
MG/DL

 **TEMPERATURA**



36°C - 37,5°C



Los signos vitales permiten evaluar el estado de salud y el funcionamiento básico del organismo.

VALORACIÓN DEL PULSO

EN LA EVALUACIÓN INICIAL DEL PACIENTE, EL PULSO ES UN INDICADOR CLAVE.

1 ¿DÓNDE TOMARLO?

En arterias superficiales más accesibles:



CARÓTIDA (Cuello) RADIAL (Muñeca) BRAQUIAL (Pliegue del codo) FEMORAL (Ingle)

2 ¿QUÉ EVALUAR?

FRECUENCIA
Latidos por minuto (lpm)

RITMO
Regular o irregular

AMPLITUD
Fuerte, débil o ausente

SIMETRÍA
Igual en ambos lados

3 VALORES NORMALES DE FRECUENCIA (EN REPOSO) ADULTOS & PEDIÁTRICOS

ADULTOS	NIÑOS	LACTANTES (1 mes - 1 año)	PREESCOLARES (1 - 5 años)	ESCOLARES (6 - 12 años)	ADOLESCENTES (13 - 18 años)
60 - 100 lpm	70 - 120 lpm	100 - 160 lpm	80 - 120 lpm	70 - 110 lpm	60 - 100 lpm

4 INTERPRETACIÓN RÁPIDA

TAQUICARDIA > 100 lpm	Puede indicar fiebre, dolor, shock, ansiedad, hipovolemia.
BRADICARDIA < 60 lpm	Puede indicar hipoxia, aumento de presión intracraneal, atletas, bloqueos cardíacos.
RITMO IRREGULAR	Puede indicar arritmias (ej. fibrilación auricular).
PULSO DÉBIL	Puede indicar shock, hipovolemia, insuficiencia cardíaca.
AUSENCIA DE PULSO	Emergencia: iniciar RCP inmediatamente.

5 ¿CÓMO TOMARLO CORRECTAMENTE?

Usa la yema de los dedos índice y medio (no el pulgar).

Cuenta por 30 segundos y multiplica por 2.

Presiona suavemente, sin ocluir el flujo sanguíneo.

Asegura que el paciente esté en reposo, si es posible.

RECUERDA:
El pulso es un reflejo de la perfusión. ¡Evaluálo siempre y actúa a tiempo!

SI NO HAY PULSO:
Inicia RCP inmediatamente y activa el sistema de emergencias.

PREPARADOS PARA SALVAR VIDAS

VALORACIÓN DE LA RESPIRACIÓN

LA RESPIRACIÓN EFICAZ ES ESENCIAL PARA LA VIDA. EVALÚALA SIEMPRE ANTES DE ACTUAR.

1 ¿CÓMO EVALUAR?

En menos de 10 segundos, sin mover al paciente, observa, escucha y siente:

OBSERVA
Movimientos del pecho o abdomen.

ESCUCHA
Sonidos respiratorios (jadeos, ronquidos, etc.).

SIENTE
El aire en tu mejilla o dorso de tu mano.

2 ¿QUÉ ES UNA RESPIRACIÓN NORMAL?

Respiración tranquila, regular y eficaz.

RITMO
Regular y constante

PROFUNDIDAD
Se expande el pecho o abdomen

ESFUERZO
Sin dificultad ni uso de músculos accesorios

SONIDO
Silenciosa o suaves sonidos normales

3 TIPOS DE RESPIRACIÓN ANORMAL

TAQUIPNEA (Respiración rápida) Más de 20 respiraciones por minuto en adultos.	BRADIPNEA (Respiración lenta) Menos de 12 respiraciones por minuto en adultos.	DISPNEA (Dificultad respiratoria) Sensación de falta de aire, esfuerzo para respirar.	RESPIRACIÓN SUPERFICIAL Movimientos leves del pecho o abdomen.	RESPIRACIÓN RUIDOSA Jadeo, sibilancias, ronquidos, gorgoros.	APNEA (Ausencia de respiración) No hay respiración durante 10 segundos.
--	---	--	--	--	--

4 FRECUENCIA RESPIRATORIA NORMAL (EN REPOSO)

ADULTOS	12 - 20 respiraciones por minuto
NIÑOS (6 - 12 años)	18 - 30 respiraciones por minuto
PREESCOLARES (1 - 5 años)	20 - 30 respiraciones por minuto
LACTANTES (1 mes - 1 año)	30 - 60 respiraciones por minuto
RECÉN NACIDOS (0 - 1 mes)	30 - 60 respiraciones por minuto

5 ¿CÓMO TOMAR LA FRECUENCIA RESPIRATORIA?

OBSERVA
Los movimientos del pecho o abdomen.

CUENTA
El número de respiraciones durante 30 segundos.

MULTIPLICA POR 2
Para obtener las respiraciones por minuto.

6 ¿QUÉ HACER SEGÚN EL HALLAZGO?

RESPIRACIÓN NORMAL	Coloca al paciente en posición cómoda y vigila constantemente.
RESPIRACIÓN ANORMAL	Evalúa la causa, brinda oxígeno si está disponible y monitorea de cerca.
APNEA (SIN RESPIRACIÓN)	Activa el sistema de emergencias e inicia RCP inmediatamente.
DIFICULTAD RESPIRATORIA GRAVE	Mantén la calma, tranquiliza al paciente y busca ayuda avanzada.

SIGNOS DE ALARMA

- Dificultad para hablar
- Uso de músculos del cuello o entrecostales
- Color azul en labios o uñas
- Confusión o somnolencia
- Respiración muy rápida, muy lenta o irregular

RECUERDA:
Evaluar la respiración rápidamente puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

SI NO RESPIRA:
Inicia RCP inmediatamente y activa el sistema de emergencias.

PREPARADOS PARA SALVAR VIDAS



VALORACIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL

LA TEMPERATURA CORPORAL ES UN INDICADOR FUNDAMENTAL DEL ESTADO DE SALUD DEL PACIENTE.

1 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Permite detectar alteraciones que pueden indicar infecciones, golpe de calor, hipotermia u otras emergencias.

 INFECCIONES

 GOLPE DE CALOR

 HIPOTERMIA

 OTRAS EMERGENCIAS

2 ¿CÓMO MEDIR LA TEMPERATURA?

Usa un termómetro clínico limpio y funcional.

ORAL



- Coloca el termómetro debajo de la lengua.
- Coloca el centro de la anilla.
- Tiempo: 1 minuto.

AXILAR



- Coloca en el centro de la axila.
- Tiempo: 3-5 minutos.

TIMPÁNICA



- Usa termómetro infrarrojo en el oído.
- Tiempo: 1 segundo.

FRONTAL



- Apunta al centro de la frente.
- Tiempo: 1 segundo.

Verifica siempre el equipo antes de usarlo y sigue las instrucciones del fabricante.

3 VALORES NORMALES DE TEMPERATURA CORPORAL

SEGÚN EL SITIO DE MEDICIÓN		NORMAL 36.0 °C – 37.5 °C  Puede variar según: • Edad • Hora del día (más baja en la mañana, más alta en la tarde) • Actividad física • Vestimenta y ambiente
Oral	36.0 °C – 37.5 °C	
Axilar	35.5 °C – 37.0 °C	
Timpánica	35.8 °C – 37.8 °C	
Frontal	36.1 °C – 37.5 °C	

FEBRÍCULA

37.6 °C – 38.0 °C

Elevación leve de la temperatura. Vigila y reevalúa.

PIEBRE

38.1 °C – 39.5 °C

Indica posible infección u otra condición. Evalúa la causa.

PIEBRE ALTA

> 39.5 °C

Riesgo de complicaciones. Intervención médica prioritaria.

La temperatura rectal NO se recomienda en el ámbito prehospitalario, excepto en casos específicos y con entrenamiento.

4 CAUSAS FRECUENTES DE ALTERACIONES

AUMENTO DE TEMPERATURA

- Infecciones (virus, bacterias)
- Reacciones inflamatorias
- Golpe de calor
- Deshidratación
- Ejercicio intenso
- Estrés, ansiedad



DISMINUCIÓN DE TEMPERATURA

- Exposición al frío
- Hipotermia
- Shock
- Desnutrición
- Trastornos endocrinos
- Medicamentos



5 FACTORES QUE PUEDEN ALTERAR LA MEDICIÓN

 Ejercicio reciente

 Comer o beber líquidos calientes o fríos

 Baño reciente

 Ambiente muy cálido o frío

 Ciertos medicamentos

Ten en cuenta estos factores antes de interpretar el resultado.

6 ¿QUÉ HACER SEGÚN EL HALLAZGO?

 **TEMPERATURA NORMAL**

Continúa evaluación y monitoreo. Mantén condiciones confortables.

 **FEBRÍCULA O FIEBRE**

Evalúa otros signos y síntomas. Identifica y trata la causa.

 **PIEBRE ALTA**

Prioriza la atención. Controla la causa y sigue protocolos.

 **HIPOTERMIA**

Abriga al paciente. Previene más pérdida de calor. Busca atención médica inmediata.

 **RECUERDA**

La temperatura es solo una parte del cuadro clínico. Evalúa siempre al paciente de forma integral.

 **TU OBSERVACIÓN PUEDE SALVAR VIDAS**





VALORACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL

LA PRESIÓN ARTERIAL ES LA FUERZA QUE EJERCE LA SANGRE CONTRA LAS PAREDES DE LAS ARTERIAS. ES UN INDICADOR CLAVE DEL ESTADO CARDIOVASCULAR.

1 ¿QUÉ ES?

Es la medida de la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias cuando el corazón late y cuando se relaja.

PRESIÓN SISTÓLICA (PAS)

- Es la presión máxima cuando el corazón se contrae.

PRESIÓN DIASTÓLICA (PAD)

- Es la presión mínima cuando el corazón se relaja.



2 ¿CÓMO MEDIRLA CORRECTAMENTE?

 **Reposo previo**
El paciente debe estar en reposo 5 minutos.

 **Posición correcta**
Sentado, espalda apoyada, pies en el suelo y brazo a la altura del corazón.

 **Colocación del brazalete**
2-3 cm por encima del pliegue del codo. Ajustado, no muy apretado.

 **Durante la medición**
No hablar, no moverse ni cruzar las piernas.

 **Registrar**
Anotar siempre los valores y la condición del paciente.

Usa un equipo calibrado y del tamaño adecuado al brazo del paciente.

3 CLASIFICACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN ADULTOS (18 AÑOS O MÁS)

CATEGORÍA	PRESIÓN SISTÓLICA (PAS) mmHg	PRESIÓN DIASTÓLICA (PAD) mmHg	COLOR
NORMAL	Menor de 120	y Menor de 80	
ELEVADA	120 – 129	y Menor de 80	
HIPERTENSIÓN GRADO 1	130 – 139	o 80 – 89	
HIPERTENSIÓN GRADO 2	140 o más	o 90 o más	
HIPERTENSIÓN GRADO 3	Mayor de 180	o Mayor de 110	
CRISIS HIPERTENSIVA	Mayor de 180	y/o Mayor de 120	

TEN EN CUENTA:

- Una sola lectura alta no diagnostica hipertensión. Requiere varias mediciones en días diferentes.
- Factores como estrés, dolor, cafeína, tabaco y ejercicio pueden elevar temporalmente la presión.
- En emergencias, enfócate en el estado clínico del paciente, no solo en el número.

4 SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ALERTA

HIPERTENSIÓN (PUEDE NO PRESENTAR SÍNTOMAS)

- Dolor de cabeza intenso
- Mareos o visión borrosa
- Zumbido en los oídos
- Dolor en el pecho
- Falta de aire
- Náuseas o vómitos

HIPOTENSIÓN

- Mareos o desmayo
- Debilidad o fatiga
- Visión borrosa
- Piel fría y sudorosa
- Náuseas
- Confusión

Ante cualquier síntoma severo, actúa según el protocolo de emergencias.

5 CAUSAS FRECUENTES

HIPERTENSIÓN

- Estrés
- Consumo excesivo de sal
- Sobrepeso u obesidad
- Falta de actividad física
- Consumo de alcohol y tabaco
- Antecedentes familiares
- Enfermedades crónicas (renal, diabetes, tiroides)

HIPOTENSIÓN

- Deshidratación
- Pérdida de sangre
- Infecciones graves
- Reacciones alérgicas (anafilaxia)
- Efectos secundarios de medicamentos
- Problemas cardíacos
- Desnutrición

6 ¿QUÉ HACER SEGÚN EL HALLAZGO?

 **PRESIÓN NORMAL**

Continúa valoración y monitoreo. Mantén hábitos saludables.

 **PRESIÓN ELEVADA O HIPERTENSIÓN GRADO 1**

Educa al paciente, recomienda control médico. Monitorea y registra los valores.

 **HIPERTENSIÓN GRADO 2 O 3**

Evalúa signos de daño a órganos blanco. Actúa según protocolo y transporta.

 **CRISIS HIPERTENSIVA**

Es una emergencia. Activa el protocolo, monitorea y transporta de forma prioritaria.

 **HIPOTENSIÓN**

Evalúa la causa, asegura la vía aérea, controla hemorragias y maneja según protocolo.

7 RECUERDA

 La presión arterial puede cambiar. No te bases solo en un número.

 Evalúa al paciente en su totalidad. Signos, síntomas y contexto son clave.

 Una valoración correcta puede salvar vidas. Tu observación marca la diferencia.

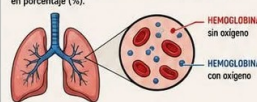


VALORACIÓN DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO (SpO₂)

LA SATURACIÓN DE OXÍGENO ES UN INDICADOR CLAVE DEL INTERCAMBIO DE GASES Y LA OXIGENACIÓN DEL PACIENTE.

1 ¿QUÉ ES?

Es el porcentaje de hemoglobina en la sangre que está transportando oxígeno. Se mide como SpO₂ y se expresa en porcentaje (%).



Una SpO₂ baja significa que los tejidos pueden no estar recibiendo el oxígeno que necesitan.

2 ¿CÓMO MEDIRLA?

Usa un oxímetro de pulso, un dispositivo no invasivo, rápido y confiable.

- Coloca el oxímetro en un dedo limpio y sin esmalte.
- Enciende el dispositivo.
- Espera unos segundos hasta que la lectura se estabilice.
- Lee el valor de SpO₂ (%) y la frecuencia de pulso.
- Registra el valor, hora y condición del paciente.

Asegúrate de que el paciente esté en reposo y con buena perfusión.

3 VALORES NORMALES DE SpO₂ EN AIRE AMBIENTE (NIVEL DEL MAR)

SpO ₂ (%)	CLASIFICACIÓN	SIGNIFICADO	ACCIÓN RECOMENDADA
95 – 100%	NORMAL	Oxigenación adecuada.	Monitorizar según condición del paciente.
91 – 94%	LIGERA HIPOXEMIA	Oxigenación ligeramente disminuida.	Evaluar causa. Considerar oxígeno suplementario si está indicado.
86 – 90%	HIPOXEMIA MODERADA	Disminución significativa del oxígeno en sangre.	Administrar oxígeno. Evaluar y tratar la causa. Monitorizar de cerca.
≤ 85%	HIPOXEMIA SEVERA	Oxigenación inadecuada. Riesgo de fallo orgánico.	Oxígeno de alto flujo. Intervención inmediata y transporte urgente.
< 80%	HIPOXEMIA CRÍTICA	Riesgo vital inminente.	Soporte avanzado de vía aérea y ventilación. Intervención inmediata.

TEN EN CUENTA:

- Los valores pueden variar en personas con EPOC (objetivo habitual: 88–92%).
- La SpO₂ no sustituye la evaluación clínica del paciente.
- Valora siempre el contexto: signos, síntomas y condición general.

4 CAUSAS FRECUENTES DE DESATURACIÓN

- Problemas respiratorios (asma, EPOC, neumonía)
- Obstrucción de la vía aérea
- Hipoventilación
- Desequilibrio ventilación/perfusión
- Anemia
- Intoxicación por monóxido de carbono
- Shock
- Insuficiencia cardíaca
- Edema pulmonar
- Altitud elevada

Siempre busca y trata la causa subyacente.

5 FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR LA LECTURA

- Esmalte de uñas oscuro o acrílico
- Manos frías o mala perfusión
- Colocación incorrecta del sensor
- Luz ambiental excesiva
- Movimiento del paciente
- Hipotensión o arritmias severas

Si la lectura parece incorrecta, verifica el sensor, la perfusión y repite la medición.

6 ¿QUÉ HACER SEGÚN EL HALLAZGO?

- SpO₂ ≥ 95% Normal: Continúa monitoreo rutinario. Mantén medidas de soporte.
- SpO₂ 91 – 94% LIGERA HIPOXEMIA: Evalúa causa. Considera oxígeno suplementario. Monitoriza.
- SpO₂ 86 – 90% HIPOXEMIA MODERADA: Administra oxígeno. Evalúa y trata la causa. Monitoriza estrechamente.
- SpO₂ ≤ 85% HIPOXEMIA SEVERA/CRÍTICA: Oxígeno de alto flujo. Intervención inmediata y transporte urgente.

7 RECUERDA

- La SpO₂ es un indicador clave, pero no el único. Evalúa siempre al paciente de forma integral.
- Una intervención oportuna puede prevenir complicaciones graves.
- Tu observación y acción pueden salvar vidas.

VALORACIÓN DE LA GLICEMIA CAPILAR CON GLUCÓMETRO

LA GLICEMIA CAPILAR ES UN INDICADOR CLAVE DEL METABOLISMO DEL PACIENTE. PERMITE DETECTAR ALTERACIONES QUE PUEDEN PONER EN RIESGO SU VIDA.

1 ¿QUÉ ES?

Es la medición del nivel de glucosa en la sangre a través de una pequeña gota obtenida del capilar (generalmente del dedo).



Mide la cantidad de glucosa disponible en ese momento para ser utilizada por las células.

No requiere ayuno. Útil en cualquier momento para evaluar al paciente.

2 ¿CÓMO MEDIRLA?

- Lava tus manos o usa guantes.
- Inserta la tira reactiva en el glucómetro.
- Punza el lateral del dedo con el dispositivo lancetador.
- Obtén una gota de sangre sin exprimir en exceso.
- Acerca la gota a la tira reactiva hasta que el equipo la absorba.
- Espera el resultado (5–10 segundos) y regístralo.

Usa siempre material estéril y deséchalo de forma segura.

3 VALORES DE REFERENCIA EN ADULTOS (mg/dL)

CLASIFICACIÓN	Glucemia (mg/dL)	SIGNIFICADO	ACCIÓN RECOMENDADA
NORMAL	70 – 140	Glucemia dentro de rangos normales.	Continúa evaluación y monitoreo según condición del paciente.
ALTERADA / EN RIESGO	141 – 200	Elevación moderada.	Evalúa causa. Monitorea y registra. Considera factores del paciente.
HIPERGLUCEMIA MODERADA	201 – 300	Elevación significativa.	Evalúa causa. Hidratación, control y transporte según protocolo.
HIPERGLUCEMIA SEVERA	> 300	Riesgo de complicaciones (cefaloedema hiperglicémico).	Atención médica inmediata. Monitoreo y transporte urgente.
HIPOGLUCEMIA	< 70	Nivel bajo de glucosa.	Riesgo de alteración neurológica. Tratamiento inmediato. Reevaluar en 15 min.

TEN EN CUENTA:

- Los valores pueden variar según la edad, condición clínica y objetivos terapéuticos del paciente.
- En pacientes diabéticos, los objetivos individuales pueden ser diferentes.
- Siempre interpreta el resultado junto con los signos, síntomas y el contexto clínico del paciente.

4 CAUSAS FRECUENTES DE ALTERACIONES

HIPERGLUCEMIA	HIPOGLUCEMIA
- Diabetes mellitus no controlada - Estrés, infecciones o fiebre - Omisión de medicamentos (insulina u orales) - Consumo excesivo de azúcares o carbohidratos - Deshidratación - Uso de corticoides	- Exceso de insulina o hipoglucemiantes - No haber comido o ayuno prolongado - Ejercicio físico intenso - Consumo de alcohol - Vómitos o diarrea - Insuficiencia hepática o renal

Ante cualquier alteración grave, actúa según el protocolo de emergencias.

5 SIGNOS Y SÍNTOMAS ASOCIADOS

HIPERGLUCEMIA	HIPOGLUCEMIA
- Sed intensa - Micción frecuente - Boca seca - Fatiga - Visión borrosa - Náuseas o vómitos - Respiración profunda (Kussmaul)	- Sudor frío - Tembor - Hambre intensa - Palpitaciones - Confusión - Irritabilidad - Pérdida de conciencia (en casos graves)

6 ¿QUÉ HACER SEGÚN EL HALLAZGO?

- HIPERGLUCEMIA (> 140 mg/dL)**
 - Evalúa causa o signos de deshidratación o infección.
 - Hidrata al paciente si está consciente y lo tolera.
 - Monitorea y registra la glucemia.
 - Transporta según protocolo y condición clínica.
- HIPOGLUCEMIA (< 70 mg/dL)**
 - Si está consciente: adminístrale 15 g de carbohidratos rápidos (ej. 3–4 tabletas de glucosa, 1/2 vaso de jugo o bebida azucarada).
 - Reevalúa en 15 minutos.
 - Si no mejora o está inconsciente: maneja vía aérea, posición lateral de seguridad e inicia protocolo de emergencias.
 - Si es posible, administra glucagón según protocolo.

7 RECUERDA

- Una sola lectura no define el diagnóstico. Siempre basa tu decisión en la evaluación integral del paciente.
- Llévate tu equipo calibrado y tiras reactivas vigentes. Verifica fecha de caducidad.
- Registra siempre el resultado, hora, condición del paciente y acciones realizadas.
- Tu valoración oportuna puede prevenir complicaciones y salvar vidas.



VALORACIÓN DEL REFLEJO PUPILAR

LA VALORACIÓN PUPILAR ES UN INDICADOR CLAVE DEL ESTADO NEUROLÓGICO DEL PACIENTE. PUEDE DETECTAR ALTERACIONES GRAVES Y AYUDAR A SALVAR VIDAS.



1 ¿QUÉ ES?

Es la respuesta normal de la pupila (el tamaño del orificio negro del ojo) ante la luz.

Reflejo fotomotor normal:
Las pupilas se contraen al recibir luz y se dilatan en la oscuridad.



⚠ La alteración del reflejo pupilar puede indicar daño neurológico o aumento de la presión intracraneal.

2 ¿CÓMO EVALUAR?



⚠ No presiones el globo ocular. No toques el ojo con la linterna.

3 EVALUACIÓN DEL REFLEJO PUPILAR NORMAL

IGUALES (Isocóricas)	REACTIVAS (Respuesta a la luz)	REDONDAS	TAMAÑO NORMAL (Adultos)	TEN EN CUENTA: - El tamaño pupilar puede variar según la edad, la luz ambiental y el estado emocional. - En la oscuridad o con poca luz, las pupilas tienden a dilatarse. - Los medicamentos, drogas y algunas enfermedades pueden alterar el reflejo pupilar.
 Ambas pupilas del mismo tamaño.	 Al iluminar, ambas pupilas se contraen.	 La forma de ambas pupilas es redonda.	 2 - 4 mm	

4 ALTERACIONES DEL REFLEJO PUPILAR

ANISOCORIA (Pupilas desiguales)	PUPILA NO REACTIVA (A la luz)	PUPILAS DILATADAS Y NO REACTIVAS	PUPILAS CONSTRICTAS Y NO REACTIVAS	PUPILA OVALADA O IRREGULAR
 Pupilas de diferente tamaño. Puede ser normal en algunas personas o indicar patología.	 No se contrae al iluminar. Puede indicar daño neurológico grave.	 Sospecha de aumento de la presión intracraneal, anoxia cerebral o intoxicación.	 Puede indicar intoxicación por opiáceos u otras causas neurológicas.	 Puede indicar lesión ocular traumática o daño neurológico.

5 CAUSAS FRECUENTES DE ALTERACIONES PUPILARES

ORIGEN NEUROLÓGICO - Traumatismo craneoencefálico - Hemorragia intracraneal - ACV (ictus) - Tumores cerebrales - Aumento de la presión intracraneal - Hipoxia/anoxia cerebral	OTRAS CAUSAS - Intoxicaciones (drogas, alcohol, medicamentos) - Opiáceos - Anticolinérgicos - Hipoglucemia severa - Lesiones oculares - Anestésicos
--	--

⚠ Siempre evalúa el contexto clínico del paciente.

6 ¿QUÉ HACER SEGÚN EL HALLAZGO?

✓ REFLEJO PUPILAR NORMAL	Continúa la evaluación y monitoreo neurológico.
⚠ ANISOCORIA LEVE (SIN OTROS SIGNOS)	Vigila y reevalúa. Puede ser normal.
⚠ PUPILA NO REACTIVA O ASIMÉTRICA	Considera una alteración neurológica. Notifica y actúa según protocolo.
⚠ PUPILAS DILATADAS Y NO REACTIVAS	Emergencia neurológica. Activa protocolo de emergencia.
⚠ CAMBIO REPENTINO EN LAS PUPILAS	Emergencia. Actúa y transporta de inmediato.

7 REGISTRA SIEMPRE

✓ **REGISTRA SIEMPRE**

- Tamaño de ambas pupilas (mm)
- Simetría (iguales o diferentes)
- Reacción a la luz (reactivas / no reactivas)
- Forma (redondas / irregulares)
- Observaciones relevantes

La documentación puede salvar vidas.

8 RECUERDA

✓ **RECUERDA**

- Evalúa siempre ambas pupilas.
- Usa la misma fuente de luz.
- Compara tamaño y reacción.
- Un cambio puede ser el primer signo de una emergencia neurológica.

⚠ SIGNOS DE ALARMA

- Pupilas desiguales y no reactivas
- Pupilas dilatadas y fijas
- Cambios pupilares súbitos
- Asociado a disminución del nivel de conciencia, vómitos, convulsiones, debilidad o trauma.



NEMOTECNIAS

ESENCIALES EN ATENCIÓN PREHOSPITALAR



1 ABCDE

EVALUACIÓN PRIMARIA

- A**  **Airway**
Vía aérea
+ control cervical
- B**  **Breathing**
Evaluar
respiración
- C**  **Circulation**
Control de
hemorragias
y pulso
- D**  **Disability**
Evaluación
neuroológica
- E**  **Exposure**
Exposición
y control térmico

2 SAMPLE

HISTORIA CLÍNICA RÁPIDA

- S**  **Signos y síntomas**
- A**  **Alergias**
- M**  **Medicamentos**
- P**  **Antecedentes**
- L**  **Última ingesta**
- E**  **Eventos relacionados**

3 OPQRST

EVALUACIÓN DEL DOLOR

- O**  **Onset** (inicio)
- P**  **Provocation / Palliation**
(qué empeora o alivia)
- Q**  **Quality** (calidad)
- R**  **Region / Radiation**
(región o irradiación)
- S**  **Severity** (severidad)
0 - 10
- T**  **Time** (tiempo)
evolución

4 AVDI

ESTADO DE CONCIENCIA

- A**  **Alerta**
- V**  **Responde a voz**
- D**  **Responde al dolor**
- I**  **Inconsciente**
(no responde)

5 MARCH

PACIENTE TRAUMÁTICO

- M**  **Massive hemorrhage**
(hemorragia masiva)
- A**  **Airway**
(vía aérea)
- R**  **Respiration**
(respiración)
- C**  **Circulation**
(circulación)
- H**  **Hypothermia / Head injury**
(hipotermia / trauma craneal)

6 DCAP-BTLS

VALORACIÓN SECUNDARIA

- D**  **Deformidades**
- C**  **Contusiones**
- A**  **Abrasiones**
- P**  **Punciones / penetraciones**
- B**  **Burns** (quemaduras)
- T**  **Tenderness** (dolor)
- L**  **Laceraciones**
- S**  **Swelling** (edema)

7 FAST

EVENTO VASCULAR CEREBRAL

- F**  **Face**
(cara caída)
- A**  **Arms**
(debilidad en brazo)
- S**  **Speech**
(alteración del habla)
- T**  **Time**
(tiempo crítico)

8 RPM

TRIAGE START

- R**  **Respiración**
- P**  **Perfusión**
- M**  **Estado Mental**

9 AEIOU-TIPS

ALTERACIÓN DEL ESTADO MENTAL

- A** **Alcohol**
- E** **Epilepsia**
- I** **Insulina**
- O** **Overdose** (sobredosis)
- U** **Uremia**
- T** **Trauma**
- I** **Infección**
- P** **Psiquiátrico / Poisoning** (intoxicación)
- S** **Stroke / Shock** (EVC / choque)

10 GCS

GLASGOW COMA SCALE

- E**  **Ocular**
(apertura ocular)
- V**  **Verbal**
(respuesta verbal)
- M**  **Motora**
(respuesta motora)

PROTOCOLO ADVI

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONCIENCIA DEL PACIENTE.

GUÍA SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA NEUROLÓGICA DEL PACIENTE.

A **Alerta**

- ✓ El paciente está despierto, orientado y responde normalmente a preguntas.

D **Verbal**

- ✓ El paciente responde solo al estímulo verbal, no parece estar alerta.

V **Dolor**

- ✓ El paciente responde únicamente ante estímulos dolorosos.

I **Inconsciente**

- ✓ El paciente no responde a ningún estímulo.

LA **ESCALA ADVI** PERMITE UNA EVALUACIÓN SIMPLE Y RÁPIDA DEL ESTADO NEUROLÓGICO DEL PACIENTE GRAVE.

- ✓ Evalúa el nivel de conciencia en segundos.
- ✓ Ayuda a priorizar el tratamiento adecuado.
- ✓ Documenta y comunica los hallazgos.






CUIDADOS DEL PACIENTE CRÍTICO: ESCALA DE COMA DE GLASGOW

EVALUACIÓN NEUROLÓGICA DEL PACIENTE CON TRAUMA O ALTERACIÓN DE CONCIENCIA.

ESCALA GLASGOW

O **APERTURA OCULAR**

7 ✓ Abre ojos espontáneamente.

+3 ✓ Abre ojos al hablarle.

+1 ✓ Abre ojos al dolor.

-1 ✓ No abre los ojos.

V **RESPUESTA VERBAL**

5 ✓ Orientado, habla coherente.

+4 ✓ Habla confuso.

+1 ✓ Palabras incoherentes.

-1 ✓ Ninguna respuesta verbal.

V **VALORACIÓN**

6 ✓ Palabras una a una.

+4 ✓ Sonido por resaca.

+1 ✓ Ninguna respuesta verbal.

I **INICIO**

6 ✓ Obedece órdenes.

+5 ✓ Localiza dolor.

+1 ✓ Retira del dolor.

-1 ✓ Flexión anormal.

-1 ✓ Horreo al alinear.

LA **ESCALA DE GLASGOW** PERMITE EVALUAR EL NIVEL DE CONCIENCIA Y GRAVEDAD DEL PACIENTE CRÍTICO.






ALICIA

PARA EVALUACIÓN DEL DOLOR

Una evaluación completa, un cuidado más humano.



A


ANTIGÜEDAD
 Inicio,
 ¿cuándo comenzó?

L


LOCALIZACIÓN
 ¿Dónde duele?
 ¿Irradiación?

I


INTENSIDAD
 Leve, moderado,
 severo

C


CARÁCTER
 Tipo de dolor: punzante,
 opresivo, quemante,
 cólico

I


IRRADIACIÓN
 ¿Se extiende
 a otras zonas?

A


**ATENUANTES /
AGRAVANTES**
 Factores que mejoran
 o empeoran el dolor


**ESCUCHAR AL PACIENTE
ES EL PRIMER PASO
PARA ALIVIAR SU DOLOR.**

ESCALA DE CINCINNATI

Detecta un EVC (Derrame Cerebral)

Una evaluación rápida puede salvar una vida.

La Escala de Cincinnati es una herramienta clínica utilizada para identificar de forma rápida y sencilla los signos de un posible accidente cerebrovascular (EVC).

! ACTÚA RÁPIDO, CADA MINUTO CUENTA.



F
FACE (ROSTRO)
 Pídele a la persona que
 sonría o muestre los dientes.
 ¿Se cae o está caído
 un lado del rostro?




A
ARMS (BRAZOS)
 Pídele a la persona que
 levante ambos brazos
 al frente con las palmas
 hacia arriba.
 ¿Un brazo se desvia
 hacia abajo?




S
SPEECH (HABLA)
 Pídele a la persona que
 repita una frase sencilla.
 ¿Su habla es confundida,
 incoherente o no puede
 hablar?




T
TIME (TIEMPO)
 Si observas uno o más
 de estos signos,
¡es hora de actuar!


 Anota la hora en que
 iniciaron los síntomas
 y busca ayuda médica
 de inmediato.

Si la persona presenta **UNO O MÁS** de estos signos, puede estar teniendo un **EVC**.


911
 LLAMA
 DE INMEDIATO


RECUERDA:
 El tratamiento oportuno puede reducir secuelas y salvar vidas.

DOLOR TORÁCICO

NO TODO ES CARDÍACO

	P	Pericarditis / Pleuritis Dolor punzante, aumenta con la inspiración o al recostarse.
	R	Reflujo gastroesofágico Ardor retroesternal, regurgitación, empeora al acostarse.
	E	Endocarditis Fiebre, soplos nuevos, antecedente de infección.
	C	Cervicoartrosis Dolor referido al tórax por patología cervical, empeora con movimientos.
	O	Osteocondritis Dolor localizado, reproducible a la palpación en un punto costal.
	R	Ruptura de cuerdas tendinosas Soplo nuevo, insuficiencia mitral aguda, disnea súbita.
	D	Disecación aórtica Dolor desgarrante, irradiado a espalda, HTA, signos de choque.
	I	Infarto agudo del miocardio Dolor opresivo, irradiado, diaforesis, náuseas, disnea.
	A	Angina / Ansiedad Dolor opresivo transitorio (angina) o asociado a crisis de ansiedad.
	L	Lung diseases (enf. pulmonar) EPOC, neumonía, TEP, asma. Disnea, hipoxemia, tos.



RECUERDA
Siempre evalúa el contexto clínico, signos vitales y factores de riesgo.
¡Tu valoración puede salvar una vida!

SIGNOS DE ALARMA

- Dolor súbito e intenso
- Disnea severa
- Hipotensión / Shock
- Déficit neurológico
- Síncope

DCAP-BLSTIC

EVALUACIÓN RÁPIDA DE TRAUMA

D	DEFORMIDAD	
C	CONTUSIÓN	
A	ABRASIÓN	
P	PENETRACIÓN	
B	BURN (QUEMADURA)	
L	LACERACIÓN	
S	SIGNO DE EDEMA	
T	TACTO (SENSIBILIDAD)	
I	INESTABILIDAD	
C	CREPITACIÓN	





EVALUAR IDENTIFICAR TRATAR

HR 120

SpO₂ 98%

PARAMÉDICOS



ZONAS DE SEGURIDAD

Conoce, respeta y trabaja en la zona correcta.



La correcta delimitación de zonas **protege** vidas, facilita el trabajo y evita accidentes.

ZONA CALIENTE

- ✓ Área del peligro inmediato.
- ✓ Donde ocurre el incendio.
- ✓ Solo personal operativo con EPP completo.
- ✓ Riesgo alto de lesiones.

ZONA CALIENTE

ZONA TIBIA

ZONA FRÍA

DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

- Conos de seguridad
- Cinta de seguridad
- Comunicación constante
- Respeto de límites

ZONA TIBIA

- ✓ Área de transición y apoyo.
- ✓ Descontaminación y cambio de EPP.
- ✓ Apoyo logístico y médico.
- ✓ Riesgo moderado.

ZONA CALIENTE

ZONA TIBIA

ZONA FRÍA

REGLAS DE ORO

- No entres a la zona caliente sin autorización.
- Respetas los límites de cada zona.
- Mantén la comunicación en todo momento.
- Tu seguridad y la de tu equipo es lo primero.

ZONA FRÍA

- ✓ Área segura fuera del peligro.
- ✓ Puesto de comando.
- ✓ Reunión, comunicación y descanso.
- ✓ Riesgo bajo.

ZONA CALIENTE

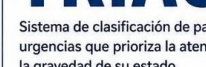
ZONA TIBIA

ZONA FRÍA

¡RECUERDA!

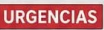
- ✓ ZONA CALIENTE = PELIGRO
- ✓ ZONA TIBIA = TRANSICIÓN
- ✓ ZONA FRÍA = SEGURIDAD

“ TRABAJAMOS EN EQUIPO, RESPETAMOS LAS ZONAS Y SALVAMOS VIDAS. ”



TRIAGE

Sistema de clasificación de pacientes en urgencias que prioriza la atención según la gravedad de su estado.



URGENCIAS

NIVELES DE TRIAGE

NIVEL	ICONO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLOS	ATENCIÓN
NIVEL I RESUCITACIÓN		RIESGO VITAL INMEDIATO Requiere atención inmediata.	• Paro cardiorrespiratorio • Shock severo • Insuficiencia respiratoria aguda • Trauma mayor	 ATENCIÓN INMEDIATA
NIVEL II EMERGENCIA		ESTADO GRAVE CON ALTO RIESGO DE DETERIORO Atención en pocos minutos.	• Dolor torácico intenso • Accidente cerebrovascular • Dificultad respiratoria moderada-severa • Hemorragia activa	 ATENCIÓN EN POCOS MINUTOS
NIVEL III URGENCIA		NECESITA ATENCIÓN MÉDICA, PERO SIN RIESGO VITAL INMEDIATO Puede esperar algunos minutos.	• Fracturas cerradas • Dolor abdominal moderado • Fiebre alta • Heridas que requieren sutura	 PUEDEN ESPERAR ALGUN TIEMPO
NIVEL IV MENOS URGENTE		PROBLEMAS DE SALUD LEVES Puede esperar más tiempo para ser atendido.	• Esguinces leves • Infecciones menores • Dolor de garganta • Molestias urinarias leves	 PUEDEN ESPERAR MÁS TIEMPO
NIVEL V NO URGENTE		CONDICIONES ESTABLES Y DE BAJA COMPLEJIDAD Atención diferible.	• Resfriado común • Renovación de recetas • Control médico rutinario • Consultas simples	 ATENCIÓN DIFERIBLE

OBJETIVOS

- Identificar rápidamente a los pacientes más graves.
- Priorizar la atención médica.
- Optimizar los recursos disponibles.
- Reducir el riesgo de complicaciones y mortalidad.

¿CÓMO SE REALIZA?

- Recepción del paciente.
- Evaluación rápida por personal capacitado.
- Asignación del nivel de triaje según la gravedad.
- Ubicación en el área correspondiente y espera de atención según prioridad.

PRINCIPIOS DEL TRIAGE

- Los pacientes se atienden según la gravedad de su condición y no por orden de llegada.
- Prioridad al paciente con riesgo vital.
- Proceso continuo: el estado del paciente puede cambiar, por lo que el triaje puede modificarse.

¡IMPORTANTE!

El triaje no es un diagnóstico, es una herramienta para priorizar la atención y **salvar vidas**.



TRIAGE EN EMERGENCIAS: ROJO, AMARILLO, VERDE Y NEGRO

Aprende a clasificar rápidamente a los pacientes según la prioridad de atención.



ROJO

**ATENCIÓN INMEDIATA,
COMPROMISO VITAL.**



- 1 Paciente inestable. Riesgo vital inmediato. Requiere intervención sin demora.

AMARILLO

**ATENCIÓN URGENTE
PERO PUEDE ESPERAR.**



- 2 Paciente estable pero con lesiones que pueden empeorar. Atención en orden de prioridad.

VERDE

**LESIONES LEVES
PUEDE CAMINAR.**



- 3 Lesiones menores. Puede caminar y esperar sin riesgo significativo.

NEGRO

**SIN SIGNOS VITALES O
LESIONES INCOMPATIBLES
CON LA VIDA SEGÚN PROTOCOLO.**



- 4 Sin respiración, sin pulso o lesiones incompatibles con la vida según criterios del protocolo.

¿CÓMO ACTUAR?



- 1 Evaluar seguridad. 
- 2 Verificar respiración y respuesta.
- 3 Clasificar según...

INDICADORES RÁPIDOS



Dificultad respiratoria:
Respira muy rápido, con esfuerzo o no puede hablar.



Sangrado:
Sangrado abundante o que no se detiene.

RECUERDA



OBSTRUCCIÓN DE VÍAS AÉREAS POR CUERPO EXTRAÑO



Actuar rápido puede **SALVAR UNA VIDA**



¿QUÉ ES?

Ocurre cuando un objeto extraño bloquea parcial o totalmente las vías aéreas, impidiendo que la persona pueda respirar, hablar o toser con normalidad.



SIGNOS DE OBSTRUCCIÓN

- No puede hablar, toser ni respirar.
- Hace ruidos agudos o no puede emitir sonido.
- Se lleva las manos al cuello (señal universal de asfixia).
- Labios o rostro pueden tornarse azulados.
- Si la obstrucción es total, puede perder el conocimiento.



Si la persona no puede toser efectivamente, actúa de inmediato.

¿QUÉ HACER?

ADULTO O NIÑO MAYOR DE 1 AÑO

1 ANIMA A TOSER

Si puede toser con fuerza, animalo a seguir tosiendo para intentar expulsar el objeto.



2 5 GOLPES EN LA ESPALDA

Colócate a un lado y ligeramente detrás de la persona. Inclínala hacia adelante y da 5 golpes firmes entre los omóplatos con la base de tu mano.



3 5 COMPRESIONES ABDOMINALES (HEIMLICH)

Si los golpes no funcionan, colócate detrás de la persona, rodea su cintura con tus brazos, coloca un puño justo arriba del ombligo y realiza 5 compresiones hacia adentro y hacia arriba.



4 REPETE EL CICLO

Alterna 5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales hasta que el objeto sea expulsado o la persona pierda el conocimiento.



NIÑO ENTRE 1 AÑO Y LA PUBERTAD

1 ANIMA A TOSER

Si puede toser, animalo a seguir tosiendo.



2 5 GOLPES EN LA ESPALDA

Colócate a un lado y ligeramente detrás del niño. Inclínalo hacia adelante y da 5 golpes firmes entre los omóplatos con la base de tu mano.



3 5 COMPRESIONES ABDOMINALES (HEIMLICH)

Si los golpes no funcionan, realiza el Heimlich igual que en el adulto, usando menos fuerza y adaptado al tamaño del niño.



4 REPETE EL CICLO

Alterna 5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales hasta que el objeto sea expulsado o el niño pierda el conocimiento.



LACTANTES (MENORES DE 1 AÑO)

1 5 GOLPES EN LA ESPALDA

Coloca al bebé boca abajo sobre tu antebrazo, con la cabeza más baja que el cuerpo. Sostén su mandíbula con tu mano y da 5 golpes firmes entre los omóplatos con la base de tu mano.



2 5 COMPRESIONES TORÁCICAS

Si no se expulsa el objeto, gira al bebé boca arriba sobre tu antebrazo. Con dos dedos en el centro del pecho (justo debajo de la línea de los pezones), realiza 5 compresiones suaves y firmes.



3 REPETE EL CICLO

Alterna 5 golpes en la espalda y 5 compresiones torácicas hasta que el objeto sea expulsado o el bebé pierda el conocimiento.





ADVANCED
CRITICAL CARE

CÓMO IDENTIFICAR UNA VÍA AÉREA DIFÍCIL EN SEGUNDOS?

CRITERIOS **HEAVEN**
PARA INTUBACIÓN DE EMERGENCIA

H



HYPOXEMIA

Baja oxigenación
del paciente.

E



EXTREMES OF SIZE

Pacientes pediátricos
o con obesidad.

A



ANATOMIC CHALLENGES

Alteraciones anatómicas
visibles.

V



VOMIT / BLOOD / FLUID

Obstrucción o
contaminación.

E



EXSANGUINATION

Compromiso
hemodinámico.

N



NECK MOBILITY

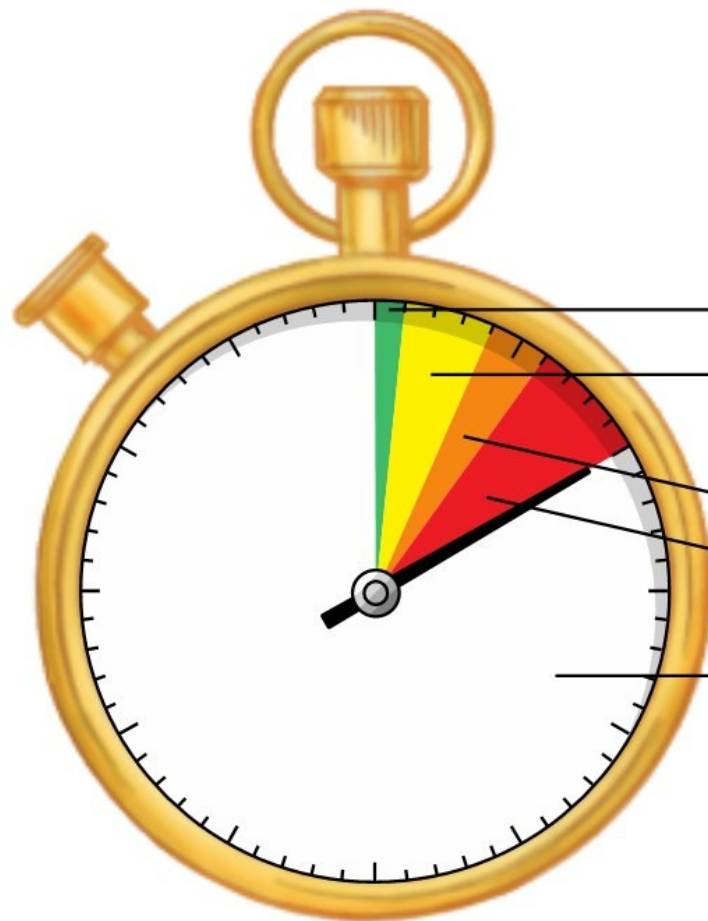
Limitación de
movimiento cervical.



LA PREPARACIÓN
Y LA ANTICIPACIÓN
PUEDEN **SALVAR VIDAS.**



ADVANCED
CRITICAL CARE



¡EL TIEMPO ES CRÍTICO!

0–1 min: irritabilidad cardíaca

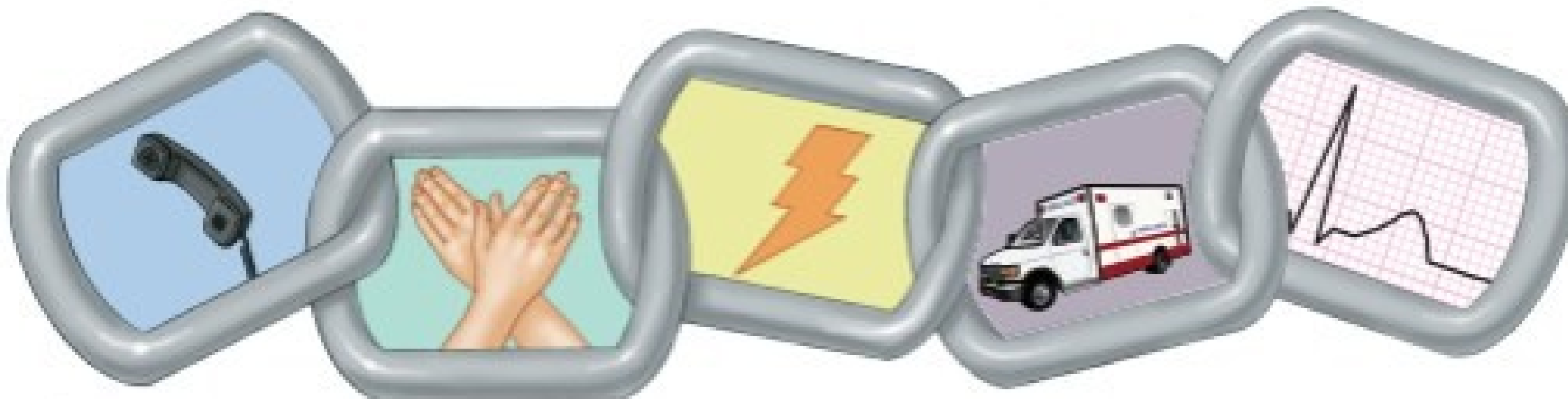
0–4 min: daño cerebral improbable

4–6 min: posible daño cerebral

6–10 min: muy probable daño cerebral

Más de 10 minutos:
Daño cerebral irreversible

Los componentes del sistema de RCP



Reconocimiento/activación
del SEM

RCP de alta
calidad inmediata

Desfibrilación
rápida

SEM básicos
y avanzados

SVA y atención
posparo

Evaluar la necesidad de SVB



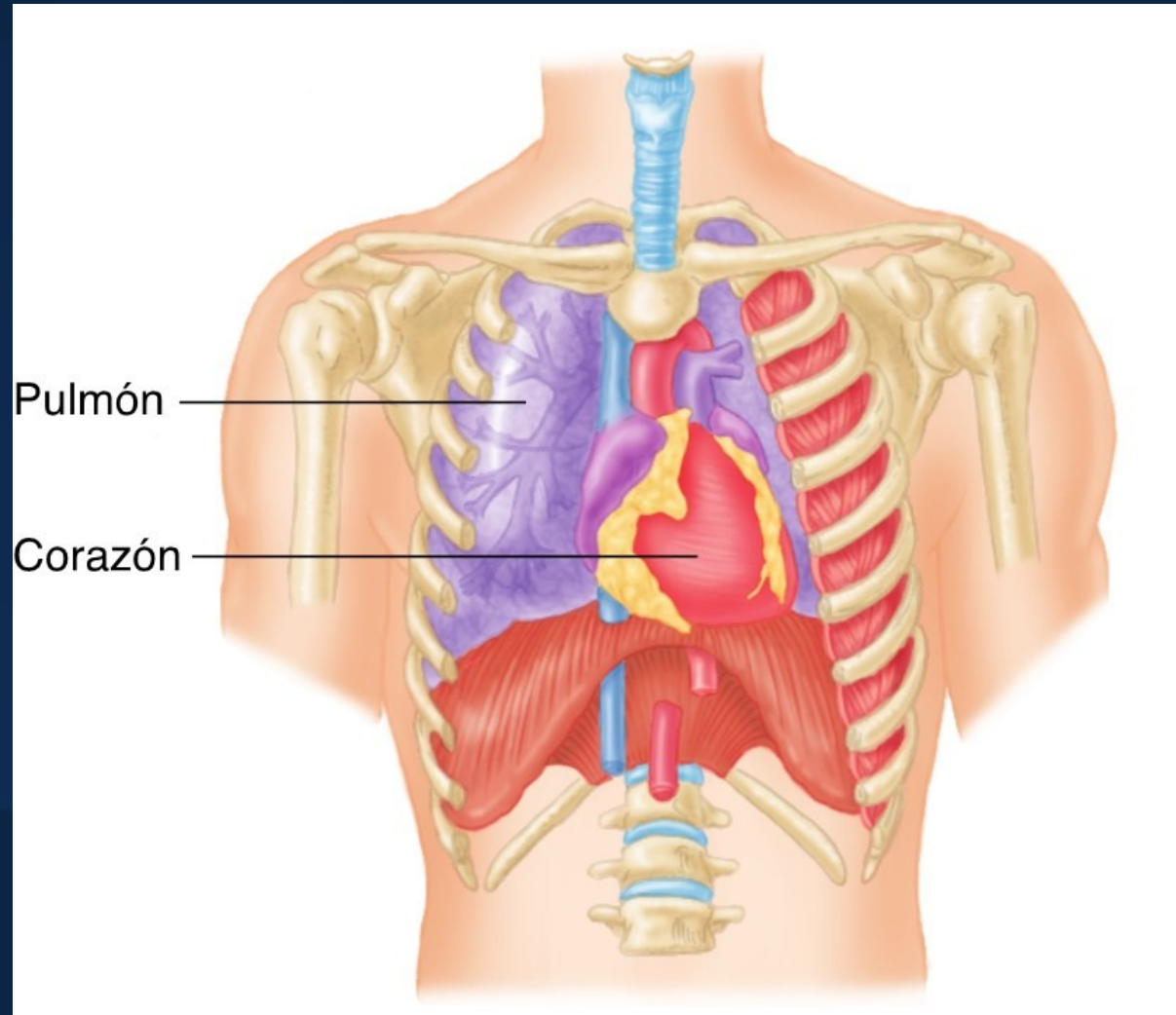
Verifique la respiración y el pulso

Verifique en forma rápida la respiración y el pulso.

Visualice el tórax en busca de signos de respiración

Palpe el pulso carotideo





Para que la RCP sea efectiva, el paciente debe estar colocado de manera supina sobre una superficie firme y plana.

Debe haber espacio suficiente para que dos rescatistas realicen la RCP.

Ruede al paciente a una tabla larga.



Proporcione compresiones torácicas externas.

Aplique presión rítmica y relajación a la mitad inferior del esternón

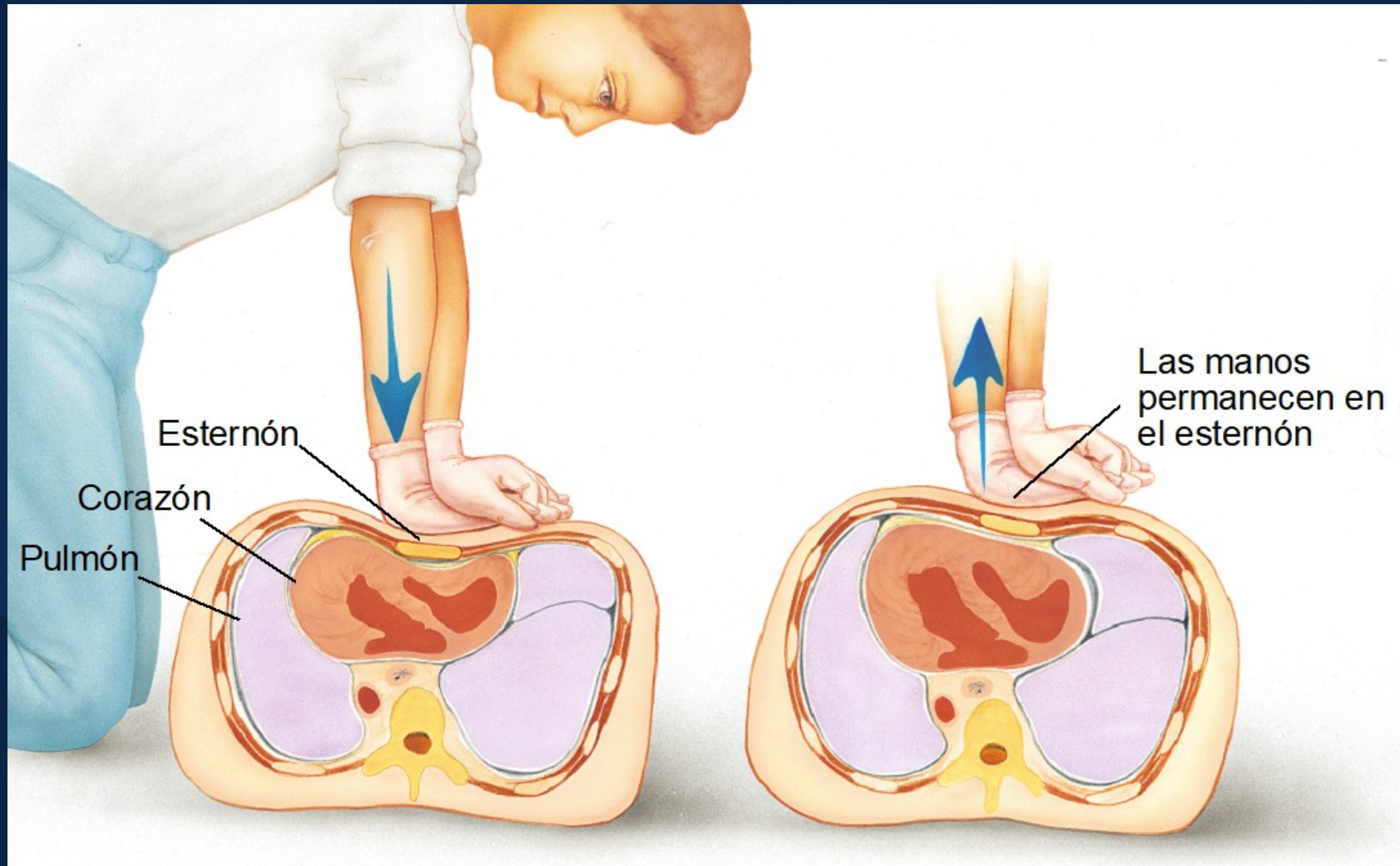
Las compresiones aprietan el corazón, actuando como una bomba para hacer circular la sangre

Evite recargarse en el tórax entre las compresiones

La colocación apropiada de la mano es crucial

Es posible minimizar las lesiones mediante la técnica y la colocación de la mano adecuadas





Primeros Auxilios

Definición O.M.S:

Son los **cuidados inmediatos** que se presta a una persona en caso de accidente o enfermedad repentina.

Con técnicas que aplicadas adecuadamente, **salvan vidas** y evitan empeorar o producir más lesiones.



3 Acciones para Salvar una Vida

Para salvar una vida es **necesario** cumplir con **tres** reglas importantes que establece la O.M.S

- P Protege**
 Protéjase Ud. Actúe solo si su vida **no corre riesgos**.
 
- A Ayuda**
 Solicite la ayuda necesaria.
 
- S Socorre**
 Realice los **Primeros Auxilios**.
 

Sistema de Triage

Triage 1 Reanimación 	Condición extrema que amenaza la vida del paciente. Requiere una intervención médica inmediata. Atención: Inmediata
Triage 2 Emergencia 	Situación de alto riesgo que representa potencial amenaza de su estado de salud. Debe recibir una atención médica rápida. Atención: Dentro de los siguientes 30 minutos .
Triage 3 Urgencia 	Condición aguda, no amenaza de la vida. Requiere consulta médica no inmediata. Atención: Hasta 2 horas .
Prioridad 4 No Urgencia 	Condición de salud que puede ser aguda, pero no compromete el estado general del paciente y no representa un riesgo evidente. Atención: De 2 hasta 4 horas .
Prioridad 4 No Urgencia 	Condición clínica relacionada con problemas agudos o crónicos sin evidencia de deterioro que comprometa el estado general del paciente. No representa un riesgo evidente para la vida. Atención: Cita por consulta externa .

Definición PCR

Paro Cardiorrespiratorio (PCR):

Se define como el cese brusco e inesperado de la respiración y circulación de forma **Potencialmente Reversible**.



PCR Adulto

- 
 Inconsciente/ No Respira
- 
 Llame al SEM ó 107 ó 911/ pida un DEA
- 
 Comience RCP

PCR Niños

- 
 Inconsciente/ No Respira
- 
 Comience RCP x 2 minutos
- 
 Llame al 107 ó 911/pida un DEA

Punto de Compresiones Torácicas

Localización:
 Adultos / Niños y Bebés:
 Centro del tórax entre las tetillas



Compresiones Torácicas



Para Adultos:
2 manos

Para Niños:
1 mano

Para Bebés:
2 dedos

Profundidad
Adultos y Niños: **5 cm**
Bebés: **4 cm**

Frecuencia
Entre **100 y 120** por minuto



Compresión

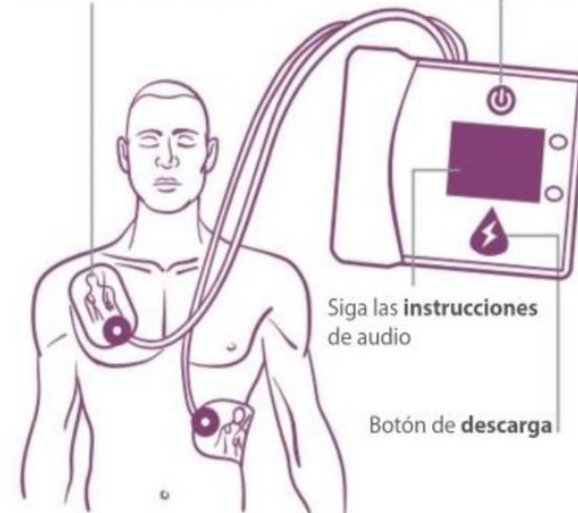


Relajación

Cómo Usar un DEA

Aplique los electrodos del DEA
en el **tórax** desnudo y seco

Encienda el DEA



Siga las **instrucciones**
de audio

Botón de **descarga**



Desfibrilador externo automático



Analiza las señales eléctricas del corazón;

Identifica la fibrilación ventricular

Aplica una descarga al corazón cuando es necesario

Desfibrilador externo automático

Los DEA son relativamente fáciles de usar.

Modelos de DEA:

Requieren un cierta interacción del operador.

El operador debe oprimir un botón para aplicar la descarga.

La mayoría tiene un sintetizador de voz de computadora que avisa qué pasos se deben tomar.



Desfibrilador externo automático

Ventajas del uso del DEA:

- Rápida aplicación de descarga

- Fácil de operar

- Los proveedores de SVA no tienen que estar en la escena

- Almohadillas adhesivas remotas de uso seguro

- Área más grande de la almohadilla = descargas más eficientes

Desfibrilador externo automático

Otras consideraciones

Aun cuando se debe analizar a todos los pacientes con paro cardíaco, no todos requieren una descarga eléctrica.

Todos los pacientes con paro cardíaco se deben analizar con un DEA.

Asistolia (línea plana) = sin actividad eléctrica

La actividad eléctrica sin pulso por lo regular se refiere a un estado de paro cardíaco.

Cómo funciona

El Desfibrilador Externo Automático está pensado para ser utilizado por personal que no trabaje en servicios de salud, pero que luego de capacitaciones y siguiendo algunas instrucciones pueda manipularlo.

Paso a paso

1 El equipo a través de luces y voz emite comandos como: solicitar ayuda, conectar el cable y poner los parches en el tórax.

2 El equipo pide analizar al paciente, sugerir reanimación cardiopulmonar, tomar un electrocardiograma y si el paciente está fibrilando pide la descarga eléctrica.

3 Se colocan los electrodos en el paciente, y el aparato, tras determinar el tipo de ritmo cardíaco, aconseja a los asistentes separarse para emitir la descarga eléctrica, o bien, realizar compresiones torácicas.

4 El equipo no solo da la descarga sino que además guía durante toda la reanimación indicando si la velocidad y profundidad de las compresiones son las adecuadas.

5 Luego de que se genera la descarga, el paciente debe ser remitido a un centro asistencial para recibir ayuda médica profesional y orientar el tratamiento a seguir.



Atención de emergencia para el paro cardíaco



Llegar a la escena

Verificar si responde · traer el DEA

No hay respuesta

Evaluar los ABC

Vía aérea abierta: pulso y respiración a la vez, máximo 10 s

Respira con pulso

Respiración adecuada: oxígeno con mascarilla sin reinhalación y posición de recuperación.
Inadecuada: ventilar 1 vez cada 5 a 6 s.
Revisar el pulso.

Sostener las ventilaciones.
Revalorar el pulso cada 2 minutos.

Sin pulso

Compresiones hasta tener el DEA

100 a 120 por minuto · 30:2 compresión : ventilación (no ventilar antes de las primeras 30).
DEA en cuanto llegue: analizar y descargar.
Tras la descarga: 5 ciclos de RCP (~2 min) y revisar el pulso, máximo 10 s.

Sigue sin pulso

Reanalizar y descargar si está indicado; luego 5 ciclos más de RCP (~2 min).

Reanalizar el ritmo

Descarga indicada: descargar y repetir.

Descarga no recomendada: reiniciar la RCP.

Con pulso

Las secuencias adicionales son según el protocolo local.

¡Gracias!

Curso de primeros auxilios



Con el apoyo de

